AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Repaso de última hora

# ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

**25** temas · 1 página cada uno

Neumología

9 temas ★★★ según preguntas reales 2013–2025 · plan de repaso de 7 días

# Índice

**Cómo usarlo.** Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.


## 01 Vía Aérea Obstructiva y Función Pulmonar

★★☆ 1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar GES ..... 3
★☆☆ 1.2. Crisis Asmática en el Adulto GES ..... 4
★★★ 1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES GES ..... 5
★★★ 1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable GES ..... 6
★★★ 1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) GES ..... 7

## 02 Infecciones Respiratorias Bajas y Supuraciones

★★★ 2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 GES ..... 8
★☆☆ 2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES GES ..... 9
★☆☆ 2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa ..... 10
★☆☆ 2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares ..... 11
★★★ 2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento GES ..... 12

## 03 Patología Pleural y Urgencias Torácicas

★★☆ 3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light ..... 13
★★☆ 3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural ..... 14
★★☆ 3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario ..... 15
★☆☆ 3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático GES ..... 16
★★☆ 3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa GES ..... 17

## 04 Oncología Pulmonar, Intersticio y Vascular

★★☆ 4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner GES ..... 18
★★★ 4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial GES ..... 19
★★★ 4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática ..... 20
★★★ 4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación ..... 21
★★★ 4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias ..... 22

## 05 Cuidados Críticos, Ventilación y Medicina del Sueño

★★☆ 5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) ..... 23
★☆☆ 5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín ..... 24
★★☆ 5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) ..... 25
★★☆ 5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo ..... 26
★☆☆ 5.5. Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental ..... 27

**Números que tienes que saber** 28
**Fármacos de primera línea** 31
**GES de la especialidad** 32
**Plan de repaso de 7 días** 34
**Índice por prioridad ★** 35

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

# 1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

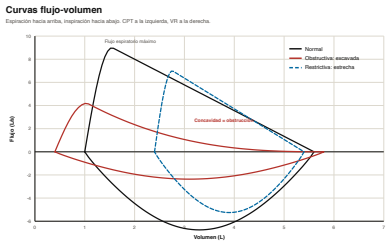
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Diagnóstico y Confirmación de Asma y EPOC en APS

| | | |
|---|---|---|
| 1.05.4.005 | Espirometría | Interpreta y emplea |
| 1.05.4.012 | Prueba de provocación bronquial con fármacos | Interpreta y emplea |

## LO QUE TE PREGUNTAN

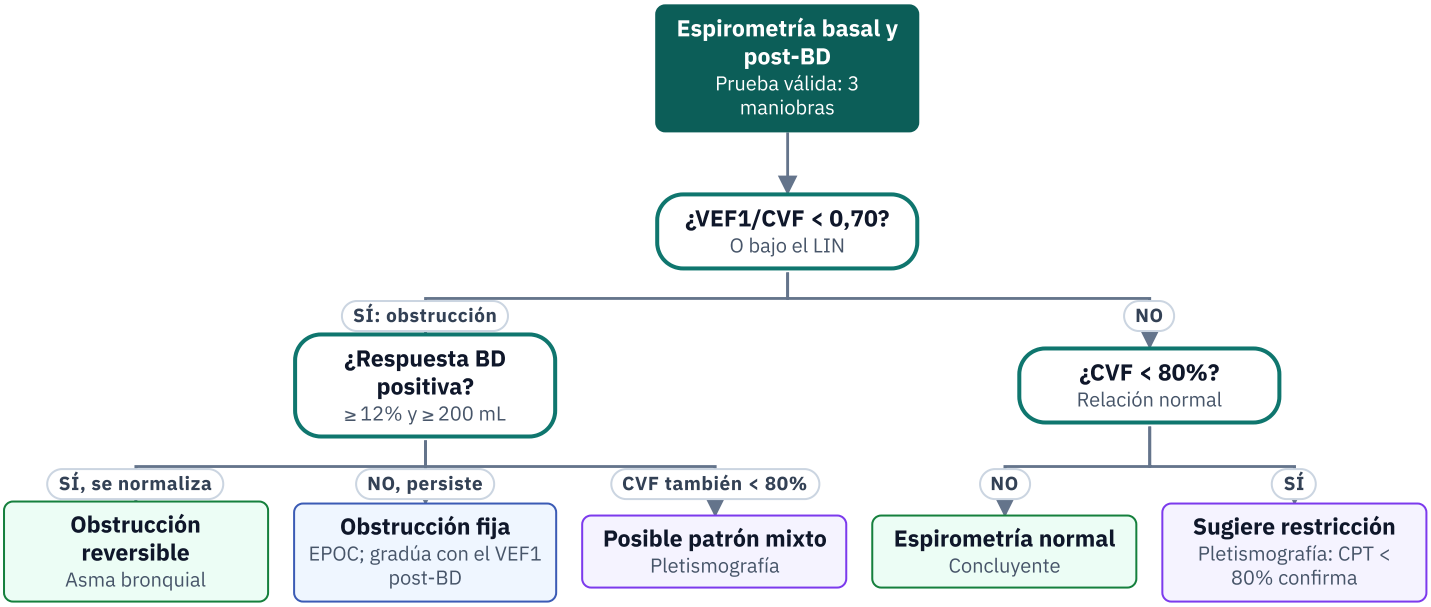
- El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.
- **Test BD positivo**: aumento del VEF1 o CVF **≥ 12%** Y **≥ 200 mL** respecto al basal.
- **La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD**: **≥80%** leve, **50-79%** moderada, **30-49%** grave, **<30%** muy grave.
- **Trampa**: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < **80%** con VEF1/CVF normal.
- La confirmación categórica de restricción pulmonar exige pletismografía demostrando CPT < **80%**.




**LAS TRES CURVAS**
Dibujo propio (esquema)

## ALGORITMO · LECTURA SISTEMÁTICA DE LA ESPIROMETRÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.1 · PATRONES ESPIROMÉTRICOS FUNDAMENTALES Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-01

| PATRÓN ESPIROMÉTRICO | VEF1/CVF | CVF (% PREDICHO) | VEF1 (% PREDICHO) | EXAMEN DE CONFIRMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Normal** | ≥ 0.70 | ≥ 80% | ≥ 80% | Espirometría normal concluyente |
| **Obstructivo Reversible** | < 0.70 | Normal o baja | Variable (mejora >12% y 200 mL) | Test Broncodilatador (Asma) |
| **Obstructivo Fijo** | < 0.70 post-BD | Normal o baja | Reducido post-BD | Espirometría post-BD (EPOC) |
| **Sugerente de Restricción** | ≥ 0.70 | < 80% | Proporcionalmente bajo | Pletismografía (CPT < 80%) |
| **Mixto (Obstr + Restr)** | < 0.70 | < 80% | Muy disminuido | Pletismografía (CPT baja + VEF1/CVF bajo) |

**REGLA DE ORO** **VEF1/CVF < 0,70 define** — El VEF1 post-BD gradúa

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **3–7** (págs. 9–10) · solucionario págs. 24–25.

**Clase 1.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR TIER 3

# 1.2 Crisis Asmática en el Adulto

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de Urgencia del Asma Bronquial Moderada o Grave

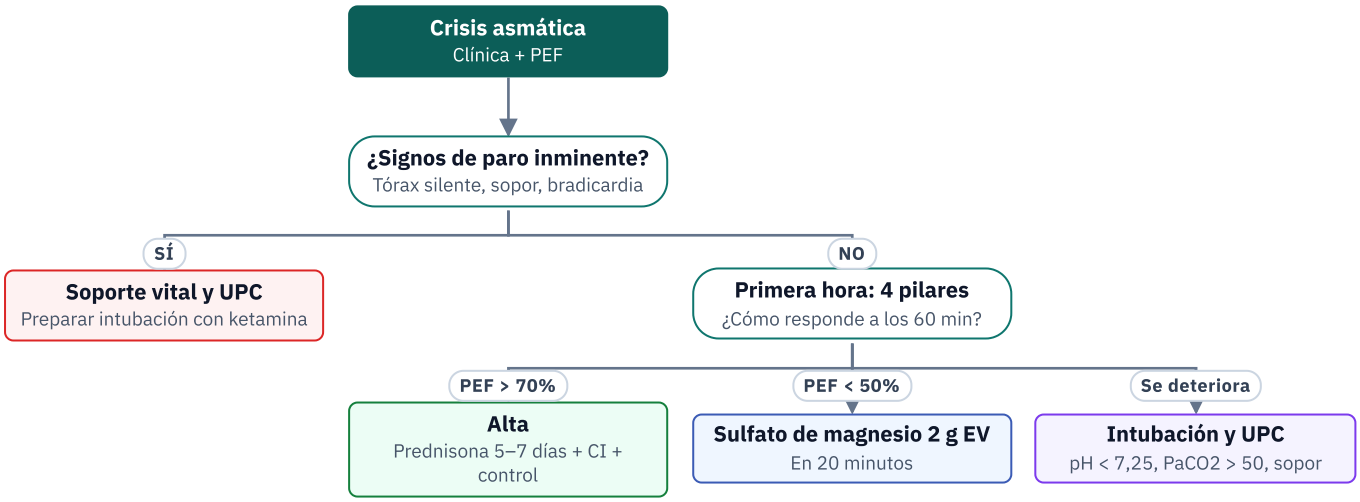
| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.2.004 | Crisis de asma bronquial | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | |
| 1.05.4.009 | Flujo espiratorio máximo (PEF: Peak Expiratory Flow) | Realiza, interpreta y emplea | |
| 1.05.4.010 | Gases en sangre arterial | Interpreta y emplea | |
| 1.05.5.008 | Nebulizaciones | Realizar | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- Un PaCO2 "normal" (**40 mmHg**) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga muscular inminente.
- El tórax silente (ausencia de sibilancias con esfuerzo respiratorio) refleja una caída crítica del flujo aéreo y riesgo inminente de paro respiratorio.
- El corticoide sistémico oral (Prednisona **40-50 mg**) tiene la misma biodisponibilidad y rapidez que la vía EV; debe administrarse en la primera hora.
- En crisis severa refractaria a SABA + Ipratropio en la primera hora, el fármaco de rescate de elección es Sulfato de Magnesio **2 g** EV en **20 minutos**.
- No se realiza pauta descendente de corticoides sistémicos si el ciclo dura entre 5 y **7 días**.

## ALGORITMO · CRISIS ASMÁTICA EN EL SERVICIO DE URGENCIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.2 · ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y GASOMÉTRICA DE LA CRISIS ASMÁTICA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-02

| SEVERIDAD | DISNEA Y HABLA | FC Y FR | PEF (% TEÓRICO) | GASES ARTERIALES (GSA) |
|---|---|---|---|---|
| **Leve / Moderada** | Párrafos o frases completas | FC < 100-110, FR < 25 | ≥ 50% - 70% | Alcalosis respiratoria (PaCO2 < 35, hipocapnia) |
| **Grave** | Frases cortas o palabras | FC > 120, FR > 30 | < 50% | Hipoxemia moderada, PaCO2 normalizante (38-42) |
| **Paro Inminente** | Incapaz de hablar, sopor | Bradicardia, agotamiento | < 30% o no medible | Acidosis respiratoria grave (PaCO2 > 45 mmHg) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-02

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Taquipneico con PaCO2 de 40** | Agotamiento inminente: preparar soporte | Leerlo como gases normales |
| **Deja de sibilar sin mejorar** | Tórax silente: riesgo de paro | Pensar que mejoró |
| **Alta de urgencia** | Prednisona 5–7 días, sin descenso | Solo salbutamol, o ciclo largo con descenso |

**REGLA DE ORO** **Palabras, FC > 120, FR > 30, PEF < 50%** — Crisis grave

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **8–10** (pág. 10) · solucionario pág. 25.

**Clase 1.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

# 1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

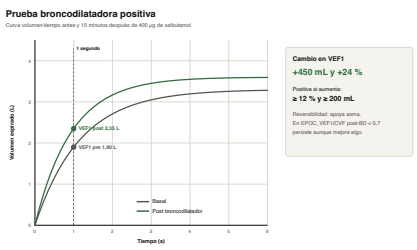
★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Asma Bronquial en Personas de 15 años y más

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.003 | Asma bronquial leve y moderada | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | 1.05.1.002 | Asma bronquial grave | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.05.4.005 | Espirometría | Interpreta y emplea | 2.01.1.019 | Asma bronquial | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |
| 1.05.1.035 | Tos crónica | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | 1.05.5.006 | Inhalación de aerosoles presurizados | Realizar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

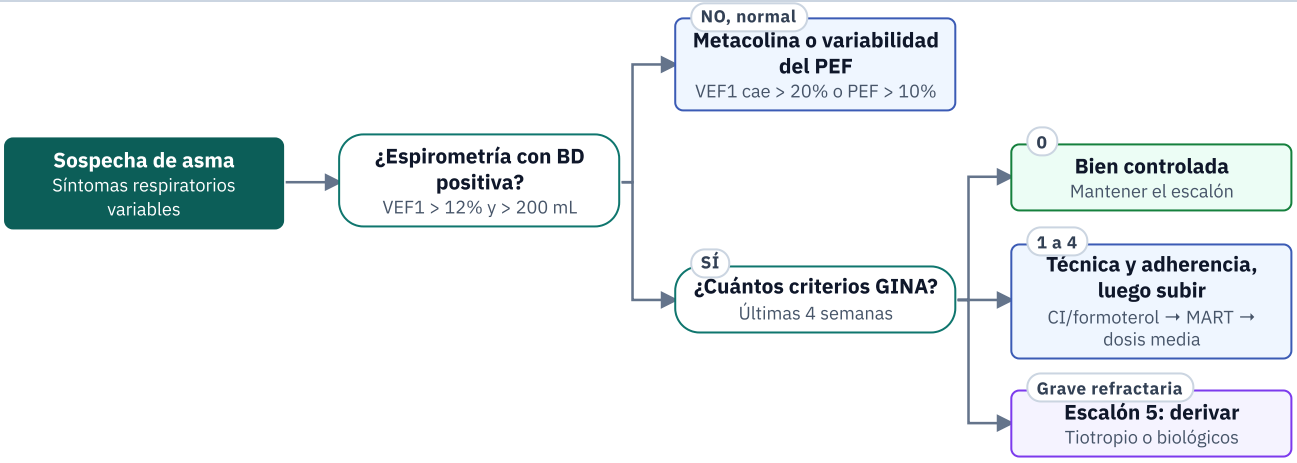
- El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo de crisis mortales.
- El corticoide inhalado (CI) es la piedra angular del tratamiento del asma crónica.
- **En cada control se evalúan 4 criterios en el último mes**: síntomas diurnos, nocturnos, uso de rescate y limitación funcional.
- Antes de subir un escalón terapéutico (Step-up), siempre revisar la técnica inhalatoria y la adherencia al fármaco.
- El tratamiento con Budesonida/Formoterol como rescate y mantenimiento (MART) reduce significativamente las exacerbaciones.




**ANTES Y DESPUÉS**
Dibujo propio (esquema)

## ALGORITMO · ASMA CRÓNICA: DIAGNÓSTICO, CONTROL Y ESCALONES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.3 · ESCALONES TERAPÉUTICOS GINA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

| ESCALÓN GINA | TRATAMIENTO PREFERIDO (VÍA 1) | ALTERNATIVA (VÍA 2) | PERFIL DE PACIENTE |
|---|---|---|---|
| **Escalón 1 y 2** | Budesonida/Formoterol dosis baja SOS | CI diario a dosis baja + SABA SOS | Síntomas < 4-5 días a la semana |
| **Escalón 3** | CI dosis baja + LABA diario + rescate MART | CI dosis baja + LABA + SABA SOS | Síntomas la mayoría de los días o despierta ≥ 1/sem |
| **Escalón 4** | CI dosis media + LABA diario + rescate MART | CI dosis media + LABA + SABA SOS | Asma no controlada con escalón 3 |
| **Escalón 5** | CI dosis alta + LABA + agregar LAMA / derivar | Evaluar fenotipo biológico (anti-IgE) | Asma grave refractaria especializada |

## TRAMPAS EUNACOM

clase resp-03

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Síntomas típicos, espirometría normal** | Test de metacolina | Descartar el asma |
| **Asmático solo con salbutamol** | Agregar corticoide inhalado | Mantener SABA en monoterapia |
| **Parcial o no controlada** | Revisar técnica y adherencia | Subir el escalón de inmediato |

**REGLA DE ORO** **Espirometría normal no descarta** — Metacolina: VEF1 cae > 20%

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **11–14** (págs. 10–11) · solucionario págs. 25–26.

**Clase 1.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

# 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en Personas de 15 años y más

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.017 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 1.05.1.016 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.4.005 | Espirometría | Interpreta y emplea | | |
| 1.05.3.004 1.01.3.007 | Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud | Conocimiento general | | |
| 1.05.1.006 | Bronquitis crónica | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 1.05.1.008 | Corazón pulmonar crónico | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

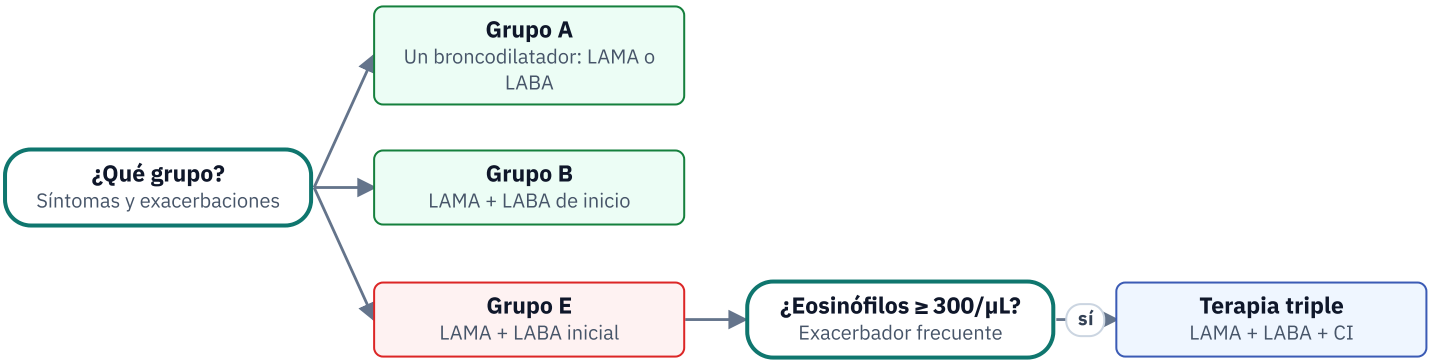
- Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el oxígeno domiciliario crónico (**≥15 h/día**).
- **Criterio de oxígeno domiciliario**: PaO2 **≤ 55 mmHg** o PaO2 **56-59 mmHg** si hay cor pulmonale o poliglobulia (Hto > **55%**).
- El esquema GOLD 2024 unificó los grupos C y D en el "Grupo E" (exacerbadores frecuentes), indicando LAMA + LABA inicial.
- Los corticoides inhalados (CI) en monoterapia están contraindicados en EPOC; aumentan el riesgo de neumonía bacteriana.
- El corticoide inhalado solo se indica como terapia triple (LABA+LAMA+CI) si los eosinófilos en sangre son **≥ 300/uL**.



**HIPERINSUFLACIÓN**
The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 22.2

## ALGORITMO · EPOC ESTABLE: DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.4 · CLASIFICACIÓN GOLD A-B-E Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INICIAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-04

| GRUPO GOLD | HISTORIAL DE EXACERBACIONES | SÍNTOMAS (MMRC / CAT) | TRATAMIENTO INICIAL RECOMENDADO |
|---|---|---|---|
| **Grupo A** | 0 o 1 moderada (sin hospitalizar) | mMRC 0-1 / CAT < 10 | Broncodilatador de larga acción (LAMA o LABA) |
| **Grupo B** | 0 o 1 moderada (sin hospitalizar) | mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10 | Doble broncodilatación: LAMA + LABA |
| **Grupo E** | ≥ 2 moderadas o ≥ 1 con hospitalización | Cualquier nivel de síntomas | LAMA + LABA (considerar CI si Eosinófilos ≥ 300/uL) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-04

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Fumador con tos, espirometría normal** | No es EPOC | Diagnosticar EPOC por el tabaco |
| **Exacerbador, eosinófilos ≥ 300/µL** | Triple: LAMA + LABA + CI | CI solo |
| **¿Qué aumenta la sobrevida?** | Dejar de fumar y oxígeno ≥ 15 h | Broncodilatadores o corticoides |

**REGLA DE ORO** **VEF1/CVF < 0,70 post-BD** — Sin obstrucción no hay EPOC

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **15–16** (pág. 11) · solucionario pág. 26.

**Clase 1.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR TIER 3

# 1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de la Exacerbación Aguda del EPOC

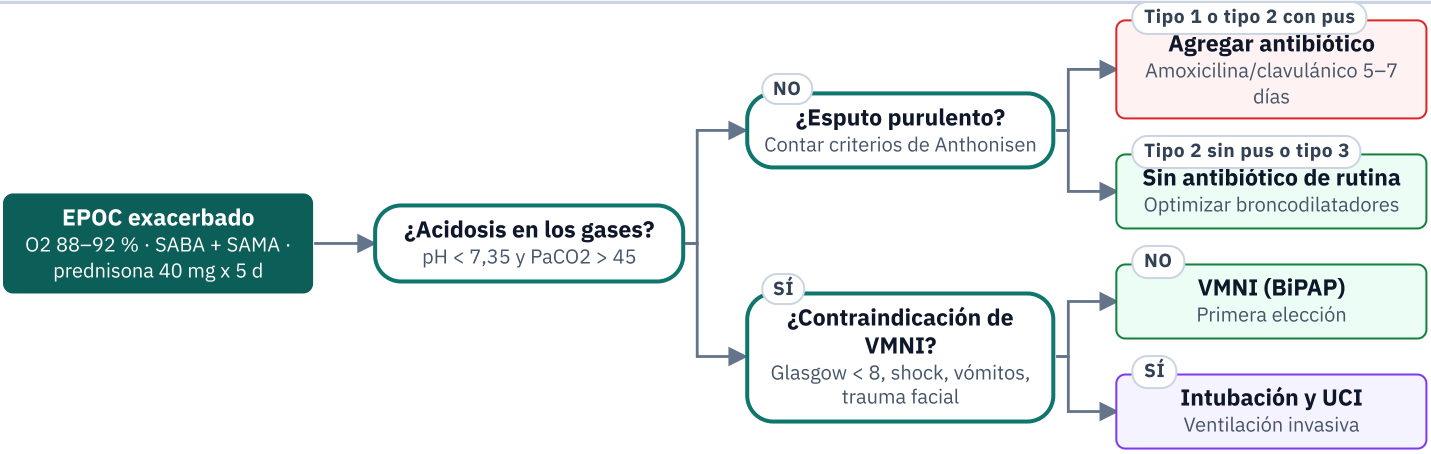
| | | |
|---|---|---|
| 1.05.2.006 | Enfermedad bronquial obstructiva crónica descompensada | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |
| 1.05.5.012 | Ventilación mecánica no invasiva | Derivar a especialista |
| 1.05.4.010 | Gases en sangre arterial | Interpreta y emplea |
| 1.01.1.004 | Corazón pulmonar crónico | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- Los criterios de Anthonisen guían la indicación de antibióticos: se indican en Tipo 1 (3 criterios) o Tipo 2 si uno de los criterios es esputo purulento.
- El patógeno bacteriano más frecuentemente aislado en las exacerbaciones de EPOC es Haemophilus influenzae.
- El esquema corticoideo de elección avalado por el estudio REDUCE es Prednisona **40 mg**/día durante exactamente **5 días** (sin pauta descendente).
- La meta de saturación en EPOC descompensado es estrictamente **88–92%**; la hiperoxia suprime la vasoconstricción hipóxica y desencadena coma hipercápnico.
- La Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP) es la indicación de elección de primera línea ante acidosis respiratoria hipercápnica (pH < 7.35 y PaCO2 > **45 mmHg**).

## ALGORITMO · EXACERBACIÓN DE EPOC: GASES Y ANTHONISEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 1.5 · CRITERIOS DE ANTHONISEN E INDICACIÓN ANTIMICROBIANA EN EXACERBACIÓN DE EPOC

| TIPO DE ANTHONISEN | CRITERIOS PRESENTES | ¿REQUIERE ANTIBIÓTICOS? | TRATAMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO |
|---|---|---|---|
| **Tipo 1 (Grave)** | Aumento disnea + aumento esputo + purulencia | SÍ (100% de los casos) | SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB |
| **Tipo 2 (Moderada)** | 2 criterios (con esputo purulento) | SÍ (por la purulencia) | SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB |
| **Tipo 2 (Moderada)** | 2 criterios (disnea + volumen SIN purulencia) | NO indicado de rutina | SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d |
| **Tipo 3 (Leve)** | 1 criterio cardinal + tos/fiebre/faringitis | NO indicado | Optimizar SABA + SAMA (reevaluar) |

## TRAMPAS EUNACOM

clase resp-05

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Más disnea + más esputo, sin purulencia** | Sin antibiótico de rutina | Dar antibiótico por tener 2 criterios |
| **EPOC desaturado en urgencia** | O2 por cánula o Venturi, meta 88–92 % | Mascarilla con reservorio a 15 L/min |
| **Somnoliento tras subir el O2** | Bajar FiO2 + VMNI | Sedar o subir más el oxígeno |

**REGLA DE ORO** **Tipo 1, o tipo 2 con purulencia** — Amoxicilina/clavulánico 5–7 días

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **17–18** (pág. 11) · solucionario pág. 26.

**Clase 1.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES TIER 3

# 2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía Adquirida en la Comunidad de Manejo Ambulatorio en Personas de 65 años y más

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.1.027 | Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias) | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar | |
| 1.05.1.005 | Bronquitis aguda | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | |
| 1.05.4.001 | Radiografía de tórax | | Interpreta y emplea |
| 1.05.4.006 | Examen microbiológico de expectoración | | Interpreta y emplea |

## LO QUE TE PREGUNTAN

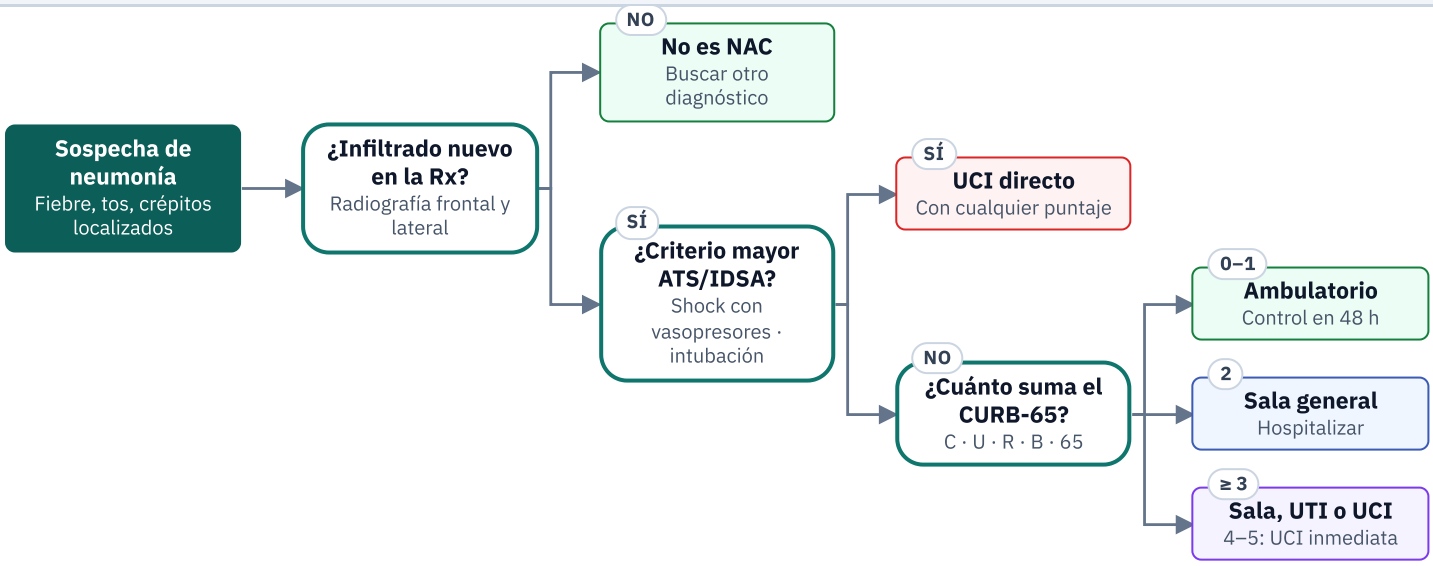
- La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.
- El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.
- **CURB-65**: Confusión (+1), Urea > **42 mg/dL** o BUN > 19 (+1), FR **≥ 30** (+1), PAS < 90 o PAD **≤ 60** (+1), Edad **≥ 65** (+1).
- **CURB-65 de 0 a 1 punto**: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. **≥ 3 puntos**: evaluar UCI/UTI.
- Si el único punto en CURB-65 es la edad (**≥ 65 años**), el paciente puede ser manejado ambulatoriamente si no hay hipoxemia ni riesgo social.
- **Criterios mayores para UCI directa según ATS/IDSA**: necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico refractario con vasopresores.



**CONSOLIDACIÓN LOBAR**
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 13

## ALGORITMO · NAC: CONFIRMAR Y DECIDIR EL LUGAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.1 · SCORE CURB-65: ESTRATIFICACIÓN DE MORTALIDAD Y SITIO DE MANEJO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-06

| PUNTAJE CURB-65 | RIESGO CLÍNICO | MORTALIDAD A 30 DÍAS | SITIO DE ATENCIÓN RECOMENDADO |
|---|---|---|---|
| **0 puntos** | Bajo | 0.7% | Ambulatorio en domicilio |
| **1 punto** | Bajo | 2.1% | Ambulatorio (si el único punto es edad ≥ 65 a) |
| **2 puntos** | Moderado | 9.2% | Hospitalización en sala general (o corta estancia supervisada) |
| **3 puntos** | Grave | 14.5% | Hospitalización en sala o UTI (evaluar criterios ATS/IDSA) |
| **4 o 5 puntos** | Muy Grave | 40.0% | Hospitalización inmediata en UCI |

**REGLA DE ORO** **Sin radiografía no hay NAC** — Infiltrado nuevo

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **19–24** (pág. 12) · solucionario págs. 26–27.

**Clase 2.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

# 2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

*Máxima · Esquemas empíricos MINSAL y ajustes según lugar de internación*

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía en el Adulto de 65 años y más (Tratamiento en menos de 24 horas)

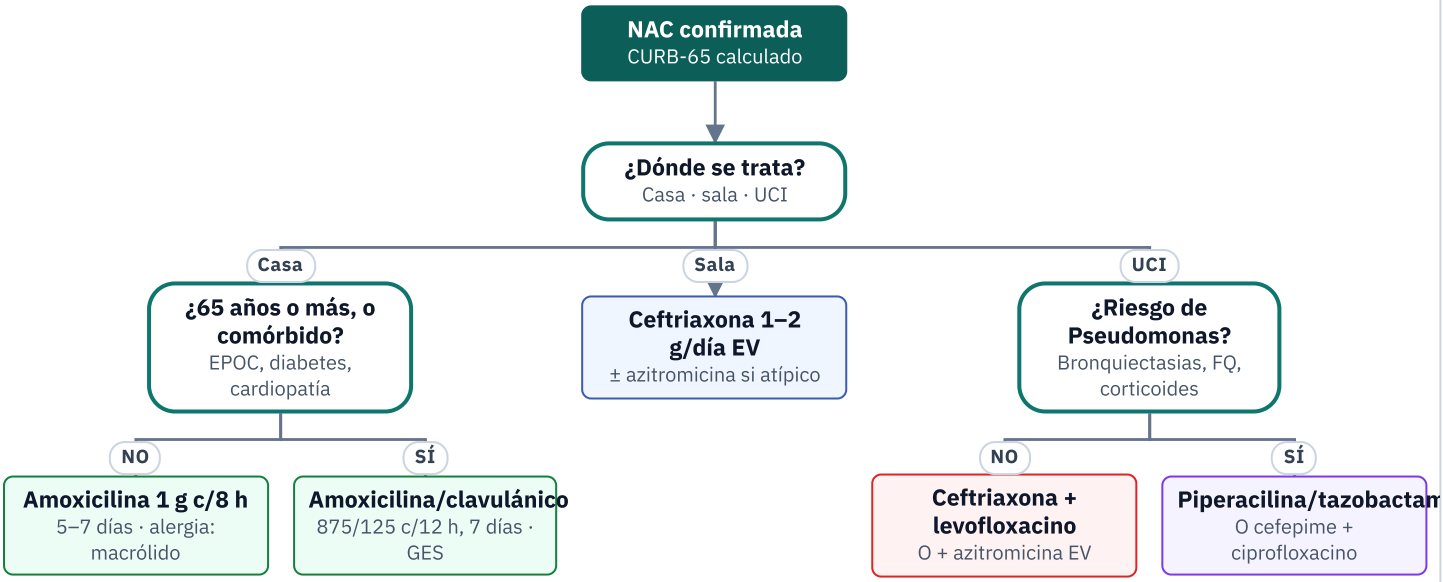
| | | |
|---|---|---|
| 1.05.1.028 | Neumonías adquiridas en la comunidad (tipos 1, 2 y 3 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias) | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades**: Amoxicilina **1 g** c/**8h** VO por **5 a 7 días**.
- **NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES)**: Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/**125 mg** c/**12h**.
- **NAC hospitalizada en sala general**: Ceftriaxona **1-2 g** al día EV (asociar Azitromicina si sospecha de atípico).
- **NAC en UCI**: Betalactámico EV (Ceftriaxona **2 g**) + Quinolona respiratoria (Levofloxacino) o Macrólido EV.
- El cambio a vía oral se realiza con **48 horas** afebril, estabilidad hemodinámica y buena tolerancia oral.

## ALGORITMO · NAC: ANTIBIÓTICO SEGÚN EL LUGAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.2 · TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO DE LA NAC SEGÚN GUÍAS CHILENAS MINSAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-07

| ESCENARIO CLÍNICO | ANTIBIÓTICO DE 1.ª LÍNEA | VÍA Y DOSIS | ALTERNATIVA ALERGIA A PENICILINA |
|---|---|---|---|
| **Ambulatorio < 65 a sano** | Amoxicilina | 1 g c/8h VO por 5-7 días | Azitromicina 500 mg/d (o Claritromicina 500 mg c/12h) |
| **Ambulatorio ≥ 65 a / comórbido (GES)** | Amoxicilina / Ácido Clavulánico | 875/125 mg c/12h VO por 7 días | Cefuroximo 500 mg c/12h o Levofloxacino 750 mg/d |
| **Hospitalizado Sala General** | Ceftriaxona (± Azitromicina) | 1-2 g/día EV (Azitro 500 mg/d VO) | Levofloxacino 750 mg/d EV o Moxifloxacino 400 mg/d |
| **Hospitalizado UCI (Grave)** | Ceftriaxona + Levofloxacino (o Azitro) | Ceftriaxona 2 g EV + Levo 750 mg EV | Levofloxacino + Vancomicina (si riesgo MRSA) |

**REGLA DE ORO** **< 65 sano: amoxicilina** — 1 g c/8 h · alergia: macrólido

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **25–26** (págs. 12–13) · solucionario pág. 27.

**Clase 2.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

# 2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.030 | Neumonías nosocomiales | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.1.027 | Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias) | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 4.01.2.017 | Supuración pulmonar | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.04.4.008 | Gram | Emplea informe | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

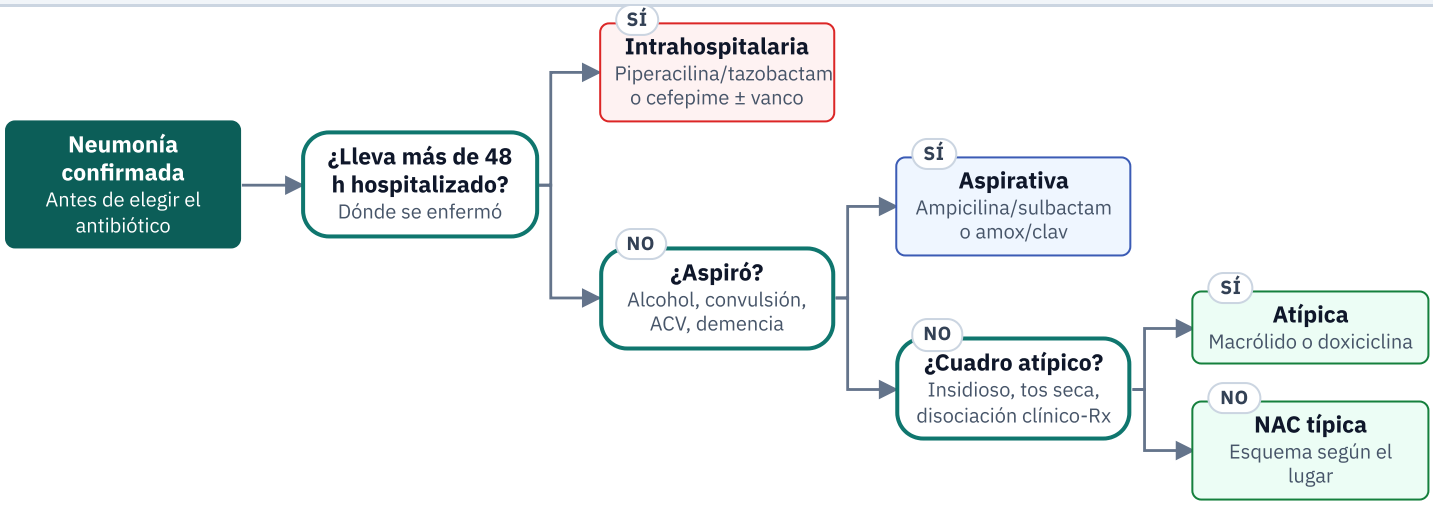
- **Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano**: son **100%** resistentes a penicilinas y cefalosporinas.
- La disociación clínico-radiológica (auscultación pobre con radiografía con extensos infiltrados) sugiere neumonía atípica.
- La neumonía aspirativa ocurre en pacientes con trastorno de conciencia o deglución y afecta segmentos declives derechos.
- **Fármaco de elección en sospecha de aspiración y anaerobios**: Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Ácido Clavulánico.
- La neumonía intrahospitalaria (NIH) se define por aparición tras **48 horas** del ingreso; exige cobertura antipseudomónica.



**MYCOPLASMA**
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 56

## ALGORITMO · NEUMONÍA: ¿SIRVE EL ESQUEMA HABITUAL?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NAC ATÍPICA VS ASPIRATIVA VS INTRAHOSPITALARIA (NIH)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-08

| TIPO DE NEUMONÍA | POBLACIÓN TÍPICA | MICROBIOLOGÍA CARDINAL | ESQUEMA TERAPÉUTICO DE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| **NAC Atípica** | Jóvenes, cuarteles, estudiantes | Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila | Azitromicina 500 mg/d o Doxiciclina 100 mg c/12h |
| **Aspirativa** | Alcohólicos, secuela ACV, demencia | Flora mixta anaerobia + estreptococos orales | Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Clavulánico |
| **Intrahospitalaria (NIH)** | Hospitalizado > 48 horas | Pseudomonas, Enterobacterias BLEE, SAMR | Piperacilina/Tazo o Cefepime (± Vancomicina) |
| **Por Legionella** | Viajeros, torres de enfriamiento | Legionella pneumophila (intracelular) | Levofloxacino 750 mg/d o Azitromicina EV |

**REGLA DE ORO** **Disociación clínico-radiológica** — Macrólido o doxiciclina

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **27–30** (pág. 13) · solucionario pág. 28.

**Clase 2.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

# 2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

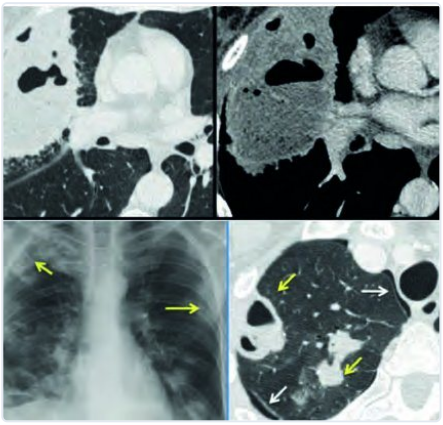
PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

*Media · Diagnóstico radiológico de cavidad con nivel hidroaéreo y manejo médico prolongado*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.001 | Absceso pulmonar | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 4.01.2.017 | Supuración pulmonar | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.5.005 | Fibrobroncoscopia | Derivar a especialista | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

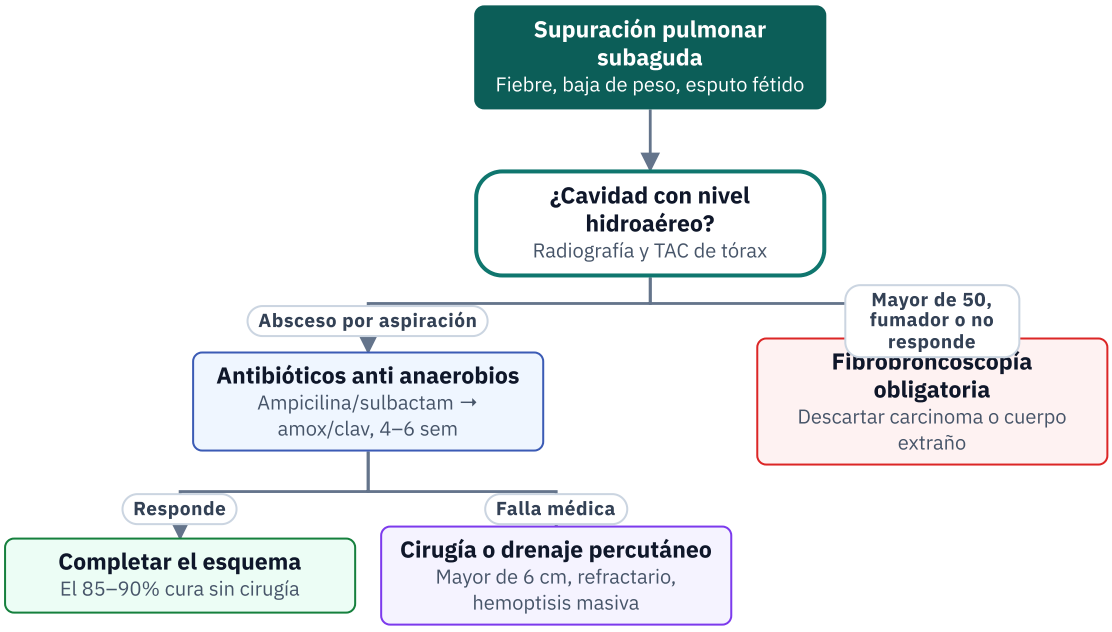
- El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo.
- El **90%** se debe a aspiración de flora oral anaerobia en pacientes con mala higiene bucal o alcoholismo.
- El tratamiento estándar es médico con antibióticos por **4 a 6 semanas** (Ampicilina/Sulbactam o Amox/Clav).
- No se indica drenaje quirúrgico de rutina; la gran mayoría drena espontáneamente por el árbol bronquial.
- En fumadores mayores de **50 años** con lesión cavitada siempre debe sospecharse y descartarse cáncer broncogénico.



**ABSCESO CON NIVEL**
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 16

## ALGORITMO · ABSCESO PULMONAR: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES CAVITADAS EN TÓRAX

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-09

| ENTIDAD CLÍNICA | PARED DE LA CAVIDAD | NIVEL HIDROAÉREO | LOCALIZACIÓN TÍPICA | TRATAMIENTO DE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Absceso Pulmonar** | Gruesa, regular por dentro | Frecuente y evidente | Segmentos dependientes (posteriores/apicales) | Ampicilina/Sulbactam oral/EV x 4-6 sem |
| **Cáncer Pulmonar Cavitado** | Muy gruesa (> 15 mm), nodular interna | Ocasional o ausente | Lóbulos superiores (carcinoma epidermoide) | Biopsia, estadificación y oncología |
| **Tuberculosis Cavitada** | Fina a moderada, halo retráctil | Raro | Segmentos apicales y posteriores superiores | Terapia 4 drogas (RHZE MINSAL) |
| **Quiste Hidatídico Complicado** | Fina con membrana desprendida | Signo del camalote / nenúfar | Bases pulmonares (más frec. derecha) | Albendazol + Cirugía conservadora |

**REGLA DE ORO** **Alcohol + mala dentadura + esputo fétido** — Anaerobios orales aspirados

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **31–34** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

**Clase 2.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES TIER 3

# 2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

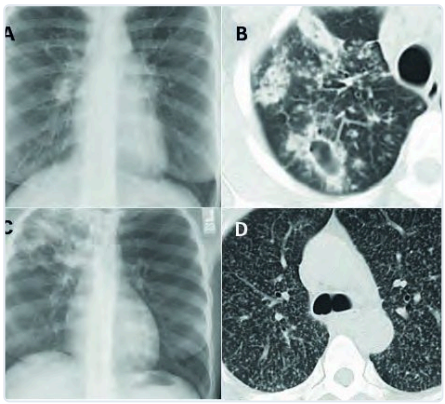
★★★ PRIORIDAD ALTA
17 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Tuberculosis en Todas sus Formas (Garantía de Acceso, Diagnóstico y Tratamiento)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.1.036 | Tuberculosis pulmonar — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | 1.05.3.003 | Programa Nacional de Control de TBC — Conocimiento general |
| 1.05.4.004 | Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración — Interpreta y emplea | 1.04.3.009 | Profilaxis de tuberculosis — Conocimiento general |
| 1.04.4.007 | Cultivo de expectoración — Interpreta y emplea | + 2 códigos relacionados: 1.04.4.015 · 1.05.3.005 | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

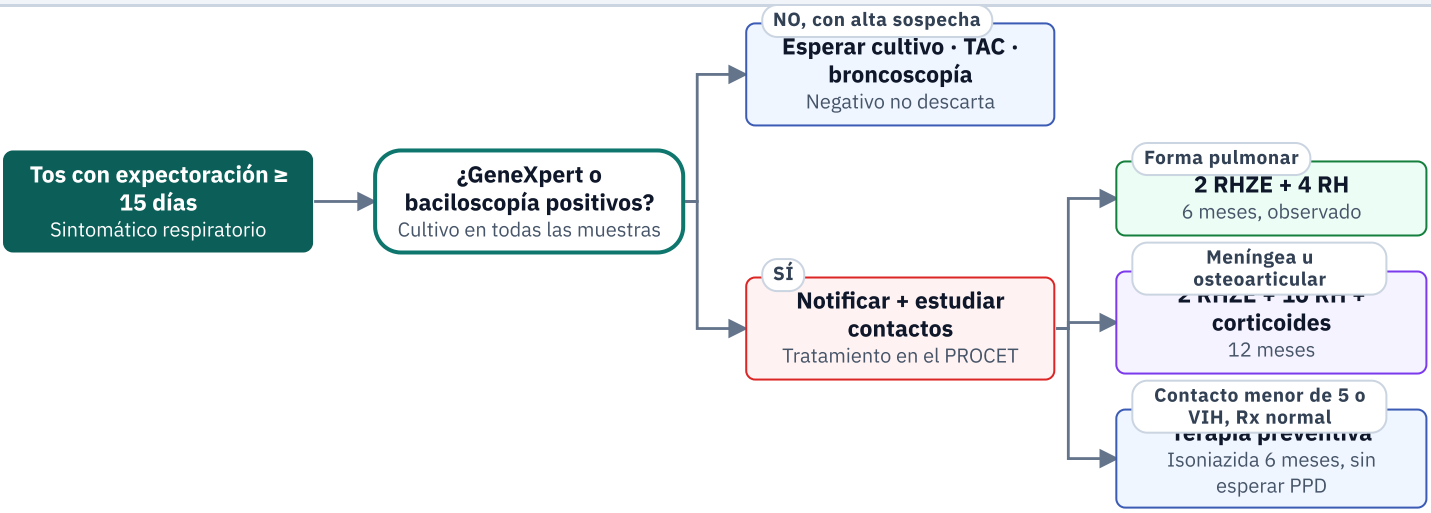
- **Sintomático respiratorio**: persona con tos y expectoración por **≥ 2 semanas** (**15 días**).
- El GeneXpert MTB/RIF detecta en **2 horas** la presencia de M. tuberculosis y la resistencia a Rifampicina.
- **Esquema primario estándar**: **2 meses** de RHZE diario + **4 meses** de RH (**6 meses** totales).
- La TBC meníngea y osteoarticular exige prolongar la terapia a **12 meses** (2 RHZE + 10 RH) y asociar corticoides.
- El Etambutol causa neuritis óptica con alteración precoz de la discriminación de colores rojo y verde (discromatopsia).




**CAVITACIÓN**
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 14

## ALGORITMO · TUBERCULOSIS: DE LA TOS A LOS CONTACTOS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 2.5 · FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS DE PRIMERA LÍNEA Y TOXICIDAD ESPECÍFICA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-10

| FÁRMACO | MECANISMO DE ACCIÓN | PRINCIPAL EFECTO ADVERSO | PERLA EUNACOM |
|---|---|---|---|
| **Isoniazida (H)** | Inhibe síntesis de ácido micólico | Neuropatía periférica y hepatitis | Prevenir con Piridoxina (Vitamina B6) |
| **Rifampicina (R)** | Inhibe ARN polimerasa | Hepatotoxicidad e inductores CYP450 | Tiñe orina y secreciones de color rojo-naranja |
| **Pirazinamida (Z)** | Altera energía y transporte en pH ácido | El más hepatotóxico e hiperuricemia | Puede desencadenar crisis de gota |
| **Etambutol (E)** | Inhibe arabinosil transferasa | Neuritis óptica retrobulbar | Pérdida de discriminación color rojo-verde |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-10

| FÁRMACO | EFECTO ADVERSO TÍPICO | CONDUCTA / PERLA |
|---|---|---|
| **Contacto < 5 años o VIH, Rx normal** | Riesgo de TBC grave | Terapia preventiva sin esperar PPD |

**REGLA DE ORO** **Tos con expectoración ≥ 15 días** — Sintomático respiratorio: se estudia

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **35–36** (pág. 14) · solucionario pág. 29.

**Clase 2.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

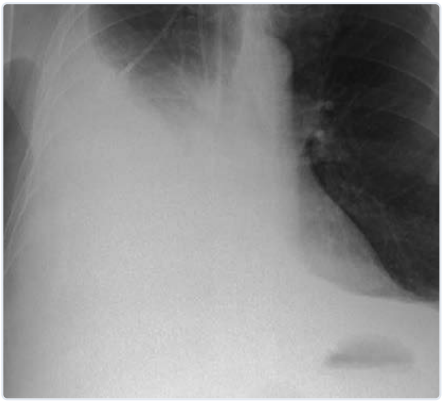
# 3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.01.1.043 | Síndrome de ocupación pleural | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | |
| 1.05.4.007 | Citoquímico de líquido pleural | Interpreta y emplea | |
| 1.05.5.009<br>4.01.5.029 | Punción pleural | Realizar | |
| 1.05.4.003 | Ecografía pleural | Emplea informe | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

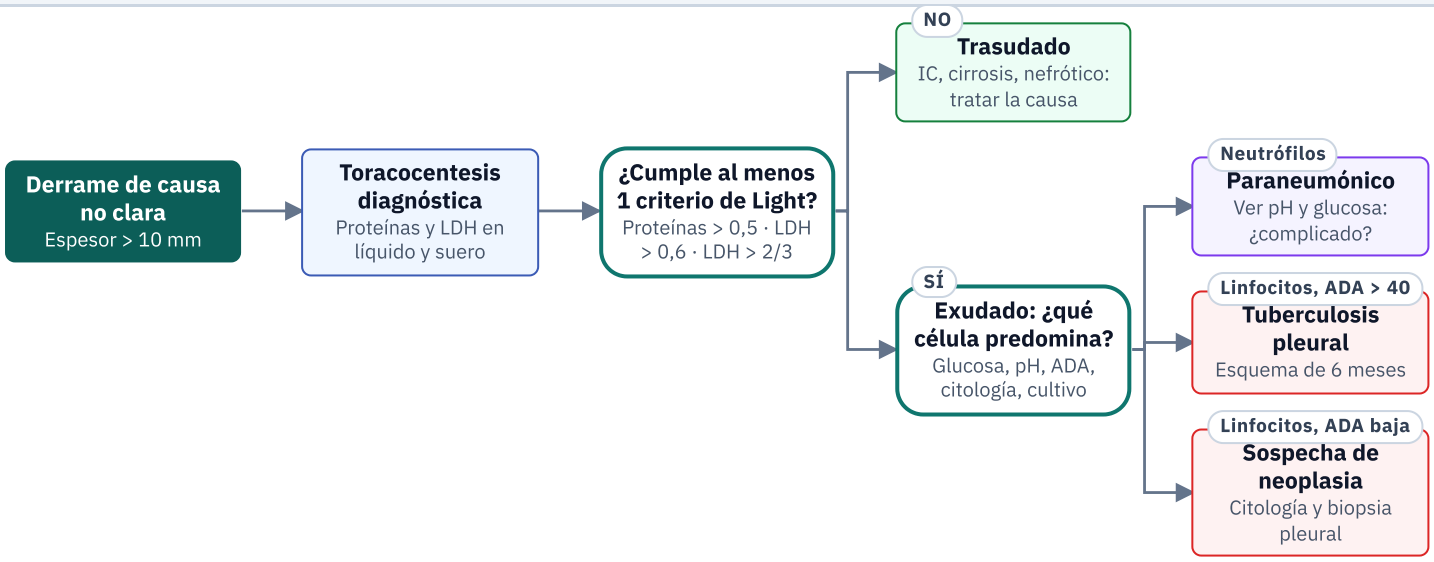
- Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.
- **Los tres criterios de Light**: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.
- La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.
- Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.
- **Trampa**: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como exudado (frecuentemente serohemático).



**DERRAME PLEURAL**
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

## ALGORITMO · DERRAME PLEURAL: DE LIGHT A LA CAUSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.1 · CRITERIOS DE LIGHT Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL LÍQUIDO PLEURAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-11

| PARÁMETRO ANALÍTICO | TRASUDADO PLEURAL | EXUDADO PLEURAL | COMENTARIO EUNACOM |
|---|---|---|---|
| **Mecanismo principal** | Aumento presión hidrostática o baja coloidosmótica | Aumento de permeabilidad microvascular pleural | El trasudado no daña la pleura |
| **Proteínas LP / Proteínas Suero** | ≤ 0.5 | > 0.5 | Basta 1 criterio positivo para exudado |
| **LDH LP / LDH Suero** | ≤ 0.6 | > 0.6 | Muy sensible para inflamación activa |
| **LDH absoluta LP** | ≤ 2/3 límite normal sérico | > 2/3 límite normal sérico | Habitualmente > 200 U/L en exudados |
| **Causas habituales** | Insuficiencia cardíaca, Cirrosis, Nefrótico | Paraneumónico, Cáncer, Tuberculosis, TEP | El TEP puede dar exudado o trasudado |

**REGLA DE ORO** **Proteínas > 0,5 · LDH > 0,6 · LDH > 2/3** — Líquido y suero al mismo tiempo

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **38–40** (pág. 15) · solucionario pág. 29.

**Clase 3.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS TIER 3

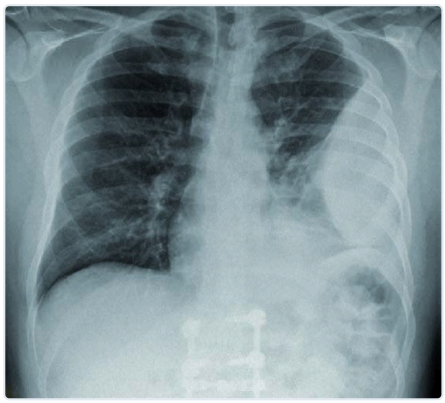
# 3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.1.011 | Derrame pleural paraneumónico complicado | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar | |
| 1.05.1.012 | Derrame pleural paraneumónico simple | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | |
| 1.05.5.004 | Drenaje pleural | Derivar a especialista | |
| 1.05.4.007 | Citoquímico de líquido pleural | Interpreta y emplea | |
| 2.01.4.010 | Citoquímico de líquido cefaloraquídeo y pleural | Interpreta y emplea | |
| + 2 códigos relacionados: 2.01.5.009 · 1.05.4.008 | | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

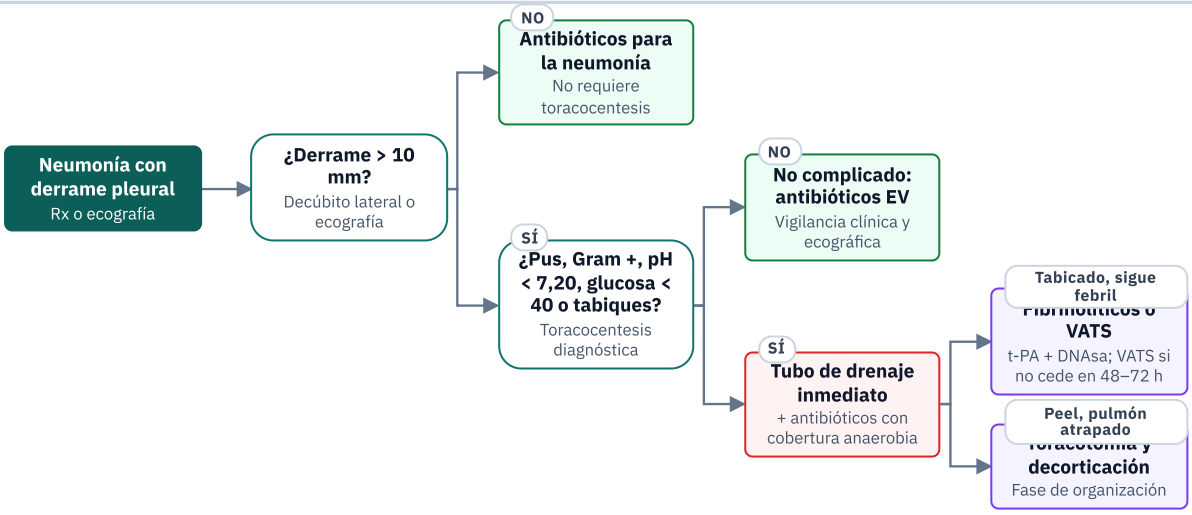
- El empiema se define por pus macroscópico franco O bacterias visibles en Gram/cultivo del líquido pleural.
- **Derrame paraneumónico complicado**: pH < 7.20, glucosa < **40-60 mg/dL** y LDH > **1.000 U/L**.
- Todo empiema o derrame paraneumónico complicado exige la instalación inmediata de un Tubo de Drenaje Torácico (pleurostomía).
- El pH del líquido pleural (< 7.20) es el parámetro bioquímico individual más sensible y específico para indicar drenaje con tubo.
- El tratamiento antibiótico empírico debe cubrir anaerobios orales (Ampicilina/Sulbactam o Ceftriaxona + Metronidazol) por **2 a 4 semanas**.



**DERRAME ENCAPSULADO**
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

## ALGORITMO · NEUMONÍA CON DERRAME: ¿ANTIBIÓTICO O TUBO?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO DEL DERRAME PARANEUMÓNICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-12

| PARÁMETRO | PARANEUMÓNICO NO COMPLICADO | PARANEUMÓNICO COMPLICADO | EMPIEMA PLEURAL |
|---|---|---|---|
| **Aspecto macroscópico** | Claro o turbio seroso | Turbio espeso | Purulento franco (pus macroscópico) |
| **pH pleural** | > 7.20 | < 7.20 | < 7.10 - 7.20 |
| **Glucosa pleural** | > 60 mg/dL | < 40 - 60 mg/dL | < 40 mg/dL (frecuentemente 0-20) |
| **LDH pleural** | < 1.000 U/L | > 1.000 U/L | > 1.000 U/L (frecuente > 3.000) |
| **Tinción Gram / Cultivo** | Negativos | Negativos o positivos | Positivos en > 70% |
| **Conducta EUNACOM** | Solo antibióticos EV | Tubo de Drenaje Pleural Inmediato | Tubo de Drenaje Pleural Inmediato |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-12

| PARÁMETRO | NO COMPLICADO | COMPLICADO | EMPIEMA |
|---|---|---|---|
| **pH** | > 7,20 | < 7,20 | < 7,10–7,20 |

**REGLA DE ORO** **Empiema: pus o Gram/cultivo +** — Complicado: pH < 7,20, glucosa < 40–60, LDH > 1.000

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **41–46** (págs. 15–16) · solucionario pág. 30.

**Clase 3.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

# 3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

*Alta · Criterios de tamaño y manejo expectante vs tubo de drenaje*

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.031 | Neumotórax moderado y grande | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.1.032 | Neumotórax pequeño | Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

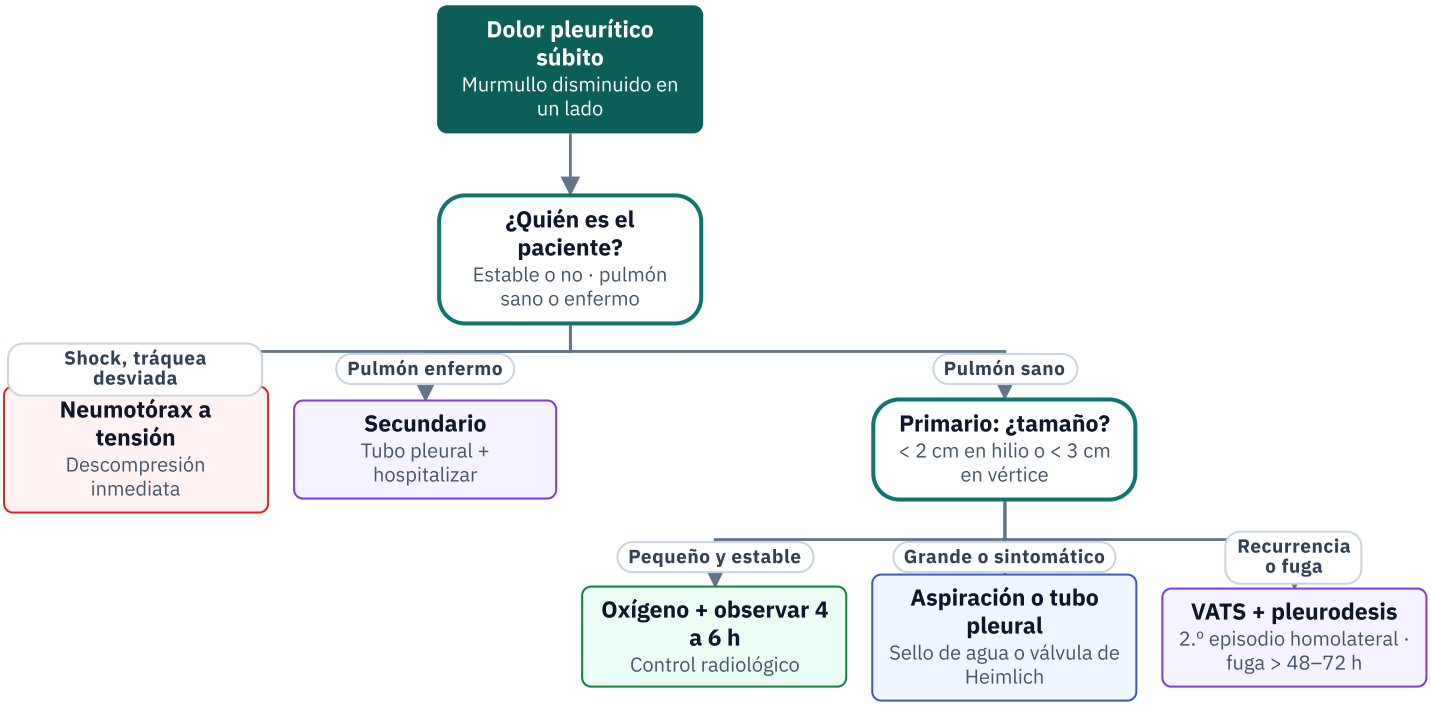
- El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de blebs apicales.
- El oxígeno suplementario a alto flujo acelera hasta **4 veces** la tasa de reabsorción del neumotórax.
- **Neumotórax primario pequeño (< 2 cm) y estable**: observación y oxígeno; no requiere punción ni tubo de entrada.
- Neumotórax secundario (en EPOC) casi siempre requiere pleurostomía con tubo de drenaje.
- La cirugía mediante VATS y pleurodesis se indica obligatoriamente ante un segundo episodio homolateral o fuga > **48-72 h**.




**INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN**
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 23

## ALGORITMO · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO: TIPO, TAMAÑO Y CIRUGÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.3 · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO (NEP) VS SECUNDARIO (NES)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-13

| CARACTERÍSTICA | NEUMOTÓRAX PRIMARIO (NEP) | NEUMOTÓRAX SECUNDARIO (NES) |
|---|---|---|
| **Población típica** | Varón joven (20-30 años), alto, delgado, fumador | Adulto mayor (> 60 años) con patología pulmonar crónica |
| **Enfermedad de base** | Ninguna (rotura de blebs apicales) | EPOC (enfisema), fibrosis, TBC secuelar, P. jirovecii |
| **Tolerancia clínica** | Buena (disnea leve, dolor pleurítico) | Mala (insuficiencia respiratoria e inestabilidad frecuente) |
| **Manejo si es pequeño** | Observación + Oxígeno normobárico | Tubo de drenaje torácico obligatorio en casi 100% |
| **Tasa de recurrencia** | 30% tras primer episodio, > 50% tras segundo | Mayor al 50% con alta mortalidad |

**REGLA DE ORO** **Primario: joven, alto, delgado** — Blebs apicales, buena tolerancia

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **47–49** (pág. 16) · solucionario págs. 30–31.

**Clase 3.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS TIER 3

# 3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

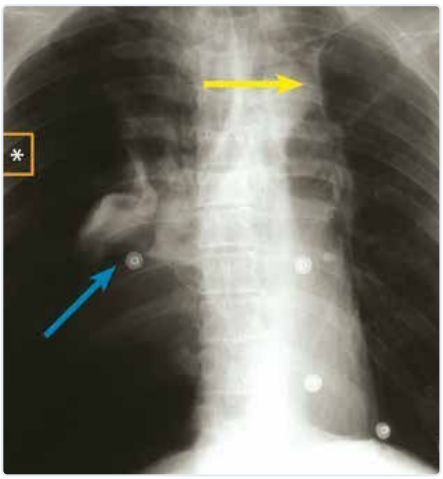
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Politraumatizado Grave (Manejo Inmediato de Lesiones Torácicas con Riesgo Vital)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.05.2.011 | Neumotórax hipertensivo | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 1.05.2.013 | Traumatismo torácico grave | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.5.004 | Drenaje pleural | Derivar a especialista | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

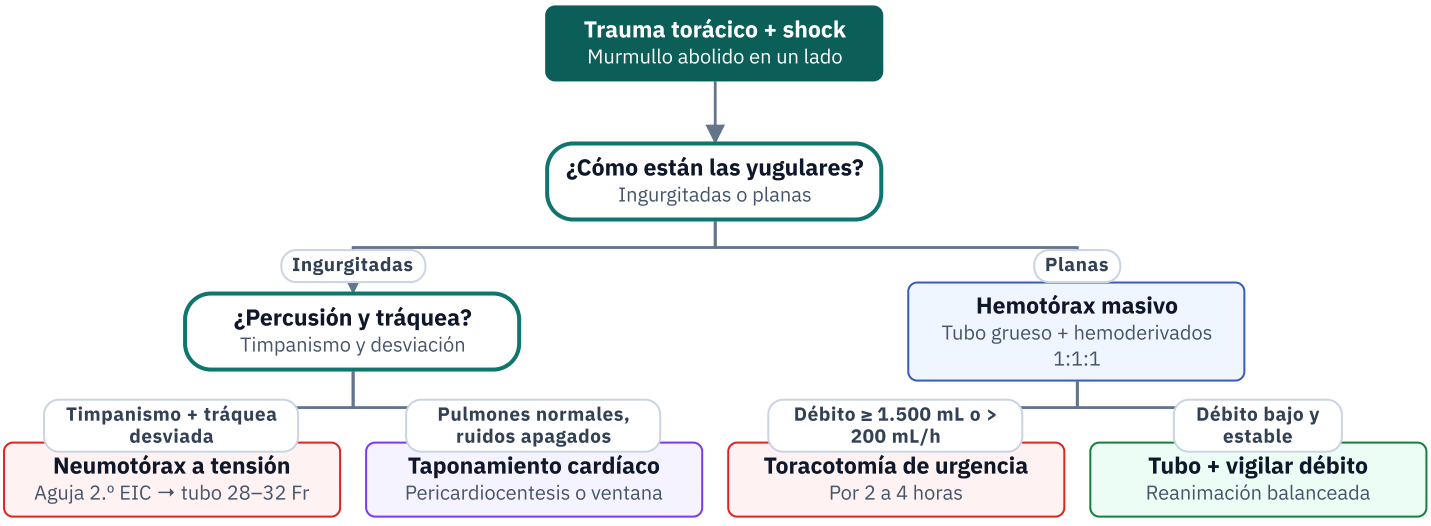
- El neumotórax a tensión es una emergencia médica con diagnóstico **100%** clínico; jamás se debe solicitar radiografía de tórax.
- **Semiología clásica**: shock obstructivo + ingurgitación yugular + hipersonoridad/timpanismo + desviación traqueal contralateral.
- **Manejo inmediato**: descompresión urgente con aguja gruesa 14-16G en 2º EIC línea medioclavicular o 5º EIC línea axilar anterior.
- La pleurostomía con tubo grueso de tórax (28-32 Fr) es el tratamiento definitivo obligatorio tras la descompresión con aguja.
- **Diferencia cardinal con hemotórax masivo**: el hemotórax cursa con matidez a la percusión y venas yugulares colapsadas por hipovolemia.
- **Criterios de toracotomía quirúrgica de urgencia en hemotórax**: drenaje inicial **≥ 1.500 mL** de sangre o débito continuo **≥ 200 mL/hora** por **2 a 4 horas**.



NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 71

## ALGORITMO · TRAUMA TORÁCICO EN SHOCK: QUÉ DICEN EL CUELLO Y LA PERCUSIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: NEUMOTÓRAX A TENSIÓN VS HEMOTÓRAX MASIVO VS TAPONAMIENTO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-14

| SIGNO CLÍNICO | NEUMOTÓRAX A TENSIÓN | HEMOTÓRAX MASIVO | TAPONAMIENTO CARDÍACO |
|---|---|---|---|
| **Presión arterial** | Shock profundo (obstructivo) | Shock hipovolémico grave | Hipotensión marcada (Tríada Beck) |
| **Yugulares** | Ingurgitadas a tensión | Planos / colapsados | Ingurgitadas a tensión |
| **Percusión torácica** | Hipersonoridad / Timpanismo | Matidez franca en base/hemitórax | Sonoridad pulmonar normal |
| **Murmullo vesicular** | Abolido ipsilateral | Disminuido o abolido ipsilateral | Murmullo pulmonar conservado bilateral |
| **Posición traqueal** | Desviada al lado contralateral | Centrada o leve desviación | Línea media estricta |
| **Tratamiento de 1ª línea** | Descompresión con aguja gruesa 14G | Tubo pleural + Hemoderivados | Pericardiocentesis o ventana pericárdica |

**REGLA DE ORO** **Shock + yugulares + tráquea desviada** — Con timpanismo: no pidas radiografía

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **37, 50–53** (págs. 14, 16–17) · solucionario págs. 29, 31.

**Clase 3.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

# 3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

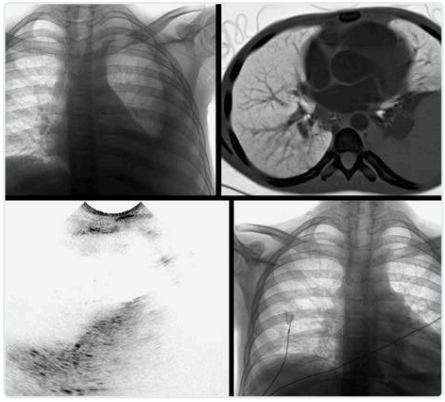
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Pulmón y Tuberculosis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.013 | Derrame pleural por tuberculosis | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |
| 1.05.1.010 | Derrame pleural neoplásico | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.5.002 | Biopsia pleural | Derivar a especialista | | |
| 4.01.1.042 | Mesotelioma pleural | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

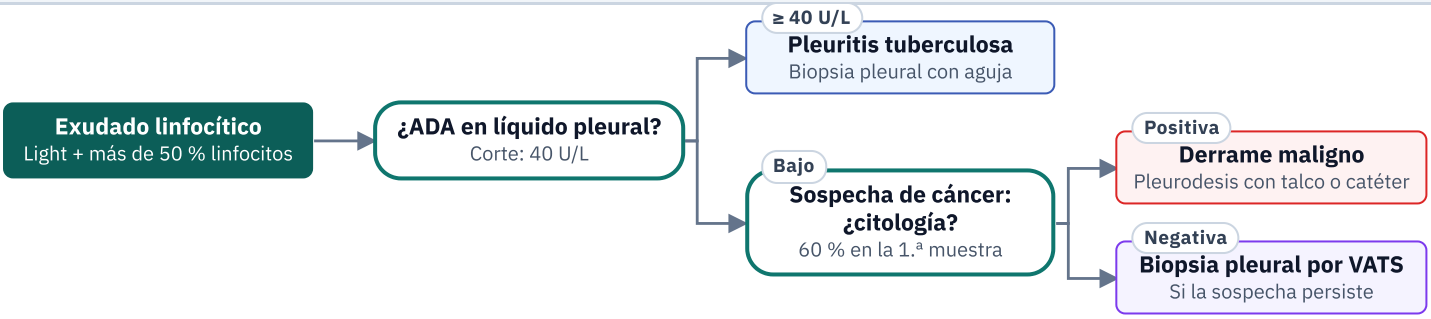
- Todo exudado pleural con > **50%** de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.
- Un ADA en líquido pleural **≥ 40 U/L** tiene altísima especificidad para pleuritis tuberculosa.
- La baciloscopía del líquido pleural tiene muy bajo rendimiento (< **10%**) en tuberculosis; la confirmación es por biopsia.
- La citología de líquido pleural diagnostica el **60%** de los derrames malignos en la primera muestra.
- El tratamiento del derrame neoplásico recidivante sintomático es la pleurodesis química con talco o catéter tunelizado.



**DERRAME NEOPLÁSICO MASIVO**
Nelson Textbook of Pediatrics, p. 3358

## ALGORITMO · EXUDADO LINFOCÍTICO: TUBERCULOSIS O CÁNCER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 3.5 · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: PLEURITIS TUBERCULOSA VS DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-15

| CARACTERÍSTICA | PLEURITIS TUBERCULOSA | DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO (MALIGNO) |
|---|---|---|
| **Edad habitual** | Jóvenes o adultos con inmunosenescencia | Adultos mayores (> 50-60 años) |
| **Aspecto del líquido** | Amarillo cetrino / serofibrinoso | Frecuentemente serohemático o hemorrágico |
| **ADA pleural** | Elevado: ≥ 40 U/L (típico > 45-50) | Bajo (< 35-40 U/L, salvo linfomas raros) |
| **Baciloscopía directa LP** | Muy baja sensibilidad (< 10%) | Negativa |
| **Citología exfoliativa LP** | Negativa para atipías | Positiva para células malignas en 60-80% |
| **Biopsia pleural** | Granulomas caseificantes (rendimiento > 80%) | Infiltración tumoral epitelial maligna |
| **Manejo definitivo** | Quimioterapia antituberculosa RHZE | Pleurodesis con talco o Catéter tunelizado (PleurX) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-15

| CARACTERÍSTICA | TUBERCULOSIS PLEURAL | DERRAME NEOPLÁSICO |
|---|---|---|
| **Tratamiento** | Esquema antituberculoso | Pleurodesis con talco o catéter |

**REGLA DE ORO** **Linfocitos > 50 %: TBC o cáncer** — El ADA decide la sospecha

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, pregunta **54** (pág. 17) · solucionario pág. 32.

**Clase 3.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

# 4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

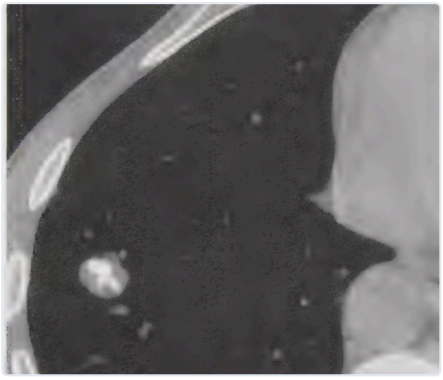
★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
5 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Sospecha de Cáncer Pulmonar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.038 | Nódulos pulmonares | Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 4.01.1.038 | Nódulo pulmonar solitario | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar |
| 1.05.4.002 | TAC de tórax | Emplea informe | | |
| 1.05.1.025 | Metástasis pulmonares | Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

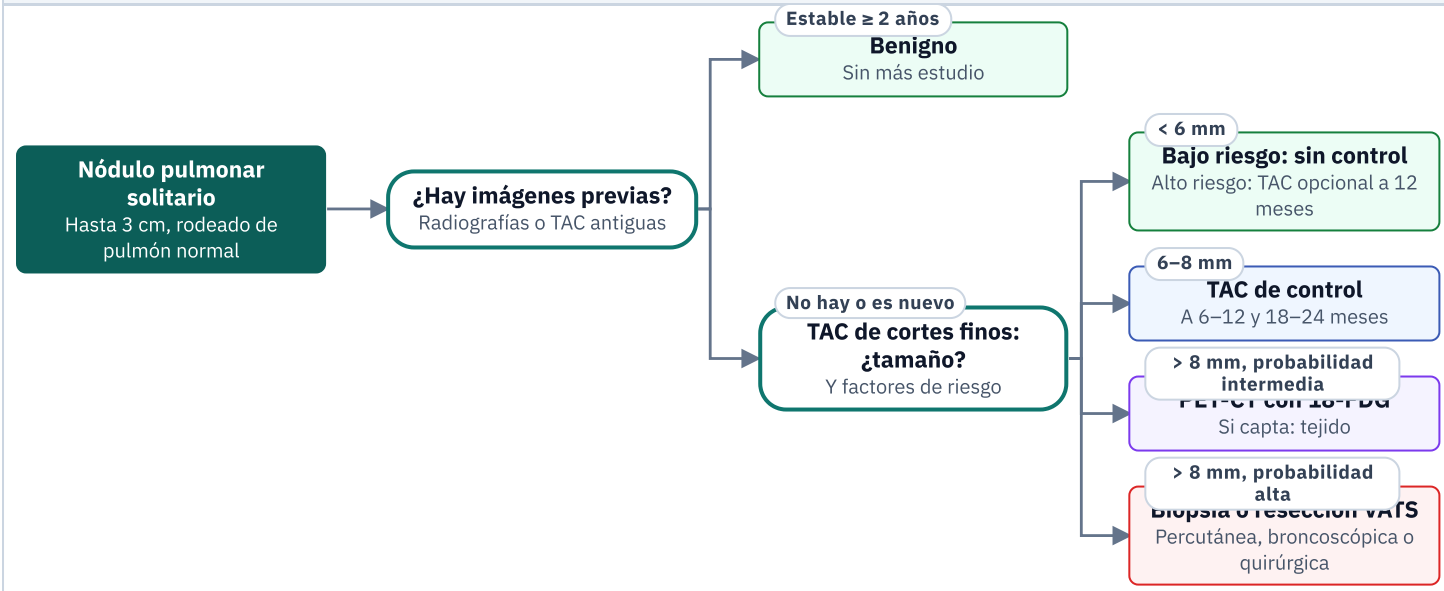
- La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.
- Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por **≥ 2 años** es benigno en el **99%** de los casos.
- La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.
- Bordes espiculados, tamaño > **8 mm** y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.
- En nódulos > **8 mm** con riesgo intermedio el examen no invasivo de elección es el PET-CT con 18-FDG.



**HAMARTOMA CON POPCORN**
Brant y Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 461

## ALGORITMO · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: DEL HALLAZGO A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: SIGNOS RADIOLÓGICOS BENIGNOS VS MALIGNOS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-16

| CARACTERÍSTICA | ALTA PROBABILIDAD DE BENIGNIDAD | ALTA PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD |
|---|---|---|
| **Tamaño** | < 6 mm (estable por ≥ 2 años) | > 8 - 10 mm (o crecimiento en controles) |
| **Márgenes / Bordes** | Lisos, netos, regulares y definidos | Espiculados, irregulares, corona radiada |
| **Patrón de calcificación** | Central, concéntrico o en popcorn (hamartoma) | Ausente, excéntrica, punteada o amorfa |
| **Densidad radiológica** | Sólida homogénea / grasa macroscópica | Parcialmente sólido (sub-sólido / vidrio esmerilado) |
| **Localización** | Cualquiera (frecuente periférico basal) | Predominio en lóbulos superiores |
| **Conducta estándar** | Comparar con previas / Observación | PET-CT, Biopsia percutánea o Resección VATS |

**REGLA DE ORO** **Primero: imágenes previas** — Estable 2 años o más: benigno

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **56–57** (págs. 17–18) · solucionario pág. 32.

**Clase 4.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

# 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

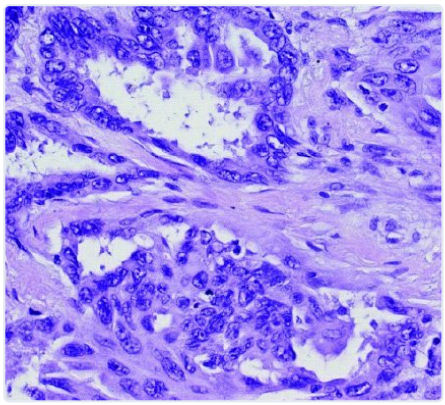
★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

**GES** Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.007 | Cáncer bronquial primario | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | 4.01.1.039 | Cáncer pulmonar | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.05.1.034 | Síndromes mediastínicos | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | 1.08.1.016 | Síndrome paraneoplásico | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.08.2.008 | Síndrome vena cava superior | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar | 1.10.1.029 | Tumores primarios y metastásicos SNC | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

## LO QUE TE PREGUNTAN

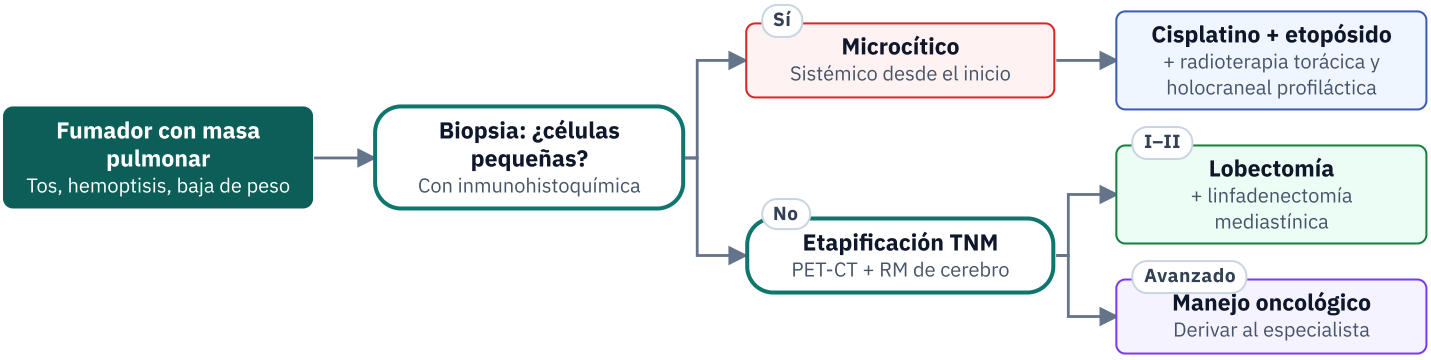
- El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras (periférico).
- El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitar y produce hipercalcemia tumoral mediada por PTHrP.
- El carcinoma microcítico es central, muy agresivo, no quirúrgico y causa SIADH, Cushing ectópico y Lambert-Eaton.
- **Tumor de Pancoast**: dolor en territorio C8-T1 más Síndrome de Horner ipsilateral (ptosis, miosis, anhidrosis).
- El tratamiento curativo del cáncer no microcítico en estadios resecables (I y II) es la lobectomía quirúrgica reglada.



**ADENOCARCINOMA**
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 125

## ALGORITMO · CÁNCER PULMONAR: DE LA MASA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 4.2 · TIPOS HISTOLÓGICOS DE CÁNCER PULMONAR Y SUS SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-17

| TIPO HISTOLÓGICO | FRECUENCIA Y UBICACIÓN | ASOCIACIÓN TABACO | SÍNDROME PARANEOPLÁSICO / HALLAZGO |
|---|---|---|---|
| **Adenocarcinoma** | 40-50% · Periférico | Fumadores y No fumadores | Osteoartropatía hipertrófica / Acropaquia |
| **Carcinoma Epidermoide** | 25-30% · Central | Fuerte asociación (cavitado) | Hipercalcemia humoral por PTHrP |
| **Carcinoma Microcítico** | 15% · Central (perihiliar) | Casi 100% fumadores pesados | SIADH (hiponatremia), Cushing (ACTH), Lambert-Eaton |
| **Células Grandes** | 10% · Periférico | Fumadores | Ginecomastia (secreción beta-HCG) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-17

| TIPO | UBICACIÓN Y FRECUENCIA | FIRMA DE EXAMEN |
|---|---|---|
| **Microcítico localizado** | Quimio + radioterapia | Error: operarlo |
| **No microcítico etapa I–II** | Lobectomía + linfadenectomía | Error: solo quimioterapia |

**REGLA DE ORO** **Microcítico: nunca cirugía** — Cisplatino + etopósido + radioterapia

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **55, 58–62** (págs. 17–18) · solucionario págs. 32–33.

**Clase 4.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

# 4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.018 | Enfermedades del intersticio pulmonar | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | 1.05.1.009 | Daño pulmonar secundario a drogas | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.05.1.026 | Neumoconiosis | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | 1.05.3.002 | Prevención de daño pulmonar por inhalantes domésticos y laborales | Conocimiento general |

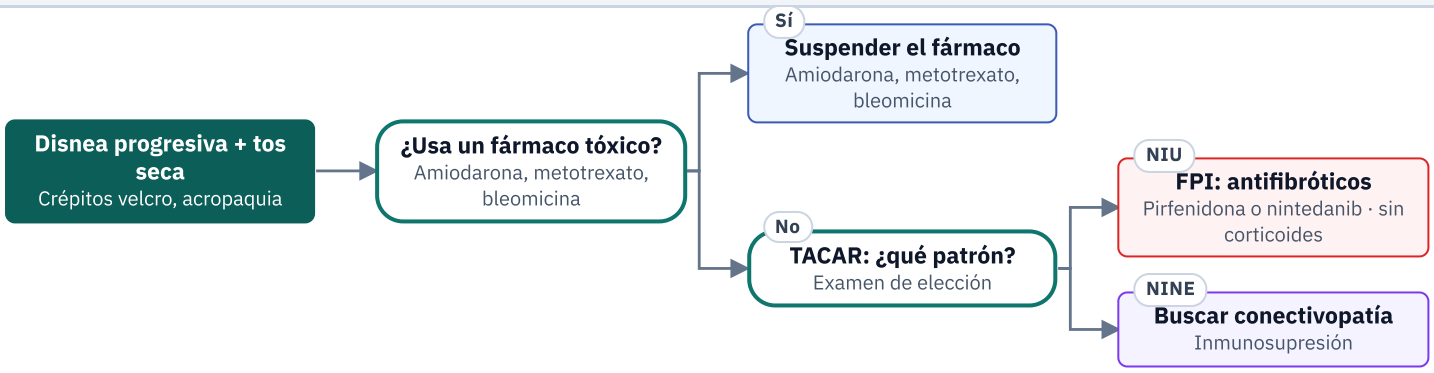
## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Semiología clásica de FPI**: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales + acropaquia.
- El patrón tomográfico en la TACAR que define a la FPI es la Neumonía Intersticial Usual (NIU) con panal de abejas.
- Si la TACAR muestra patrón NIU típico en un paciente > **60 años**, NO se requiere biopsia pulmonar.
- **Trampa de examen**: los corticoides y azatioprina están contraindicados en FPI (aumentan la mortalidad).
- El tratamiento específico de la FPI son los fármacos antifibróticos: Pirfenidona o Nintedanib.



**ACROPAQUIAS**
Manual AMIR Reumatología, p. 113

## ALGORITMO · ENFERMEDAD INTERSTICIAL: EL PATRÓN MANDA




## TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PATRÓN NIU (FIBROSIS IDIOPÁTICA) VS PATRÓN NINE (CONECTIVOPATÍAS)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-18

| CARACTERÍSTICA | PATRÓN NIU (FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA) | PATRÓN NINE (ASOCIADO A CONECTIVOPATÍAS) |
|---|---|---|
| **Población habitual** | Hombres > 60-65 años, fumadores | Mujeres jóvenes a maduras, no fumadoras |
| **Hallazgo tomográfico clave** | Panal de abejas subpleural basal + Tracción | Vidrio esmerilado predominante homogéneo |
| **Afección subpleural** | Afecta la pleura visceral inmediata | Típicamente respeta el margen subpleural |
| **Respuesta a Corticoides** | Nula / Dañina (contraindicados) | Favorable a corticoides e inmunosupresores |
| **Tratamiento específico** | Antifibróticos (Pirfenidona / Nintedanib) | Inmunosupresión (Micofenolato, Azatioprina) |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-18

| CARACTERÍSTICA | NIU (FPI) | NINE (CONECTIVOPATÍAS) |
|---|---|---|
| **Paciente típico** | Hombre > 60–65 años, fumador | Mujer joven a madura, no fumadora |
| **Zona subpleural** | Comprometida | Típicamente respetada |
| **NIU definitivo > 60 años** | Diagnóstico sin biopsia | Error: pedir biopsia |

**REGLA DE ORO** **Velcro + acropaquia** — Con disnea progresiva y tos seca

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **63–66** (págs. 18–19) · solucionario pág. 33.

**Clase 4.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR TIER 3

# 4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.015 | Embolia pulmonar | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | 1.05.2.005 | Embolia pulmonar masiva | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 4.01.4.010 | TAC de tórax | Emplea informe | 1.08.3.004 | Actividad física en pacientes con riesgo de trombosis | Conocimiento general |

## LO QUE TE PREGUNTAN

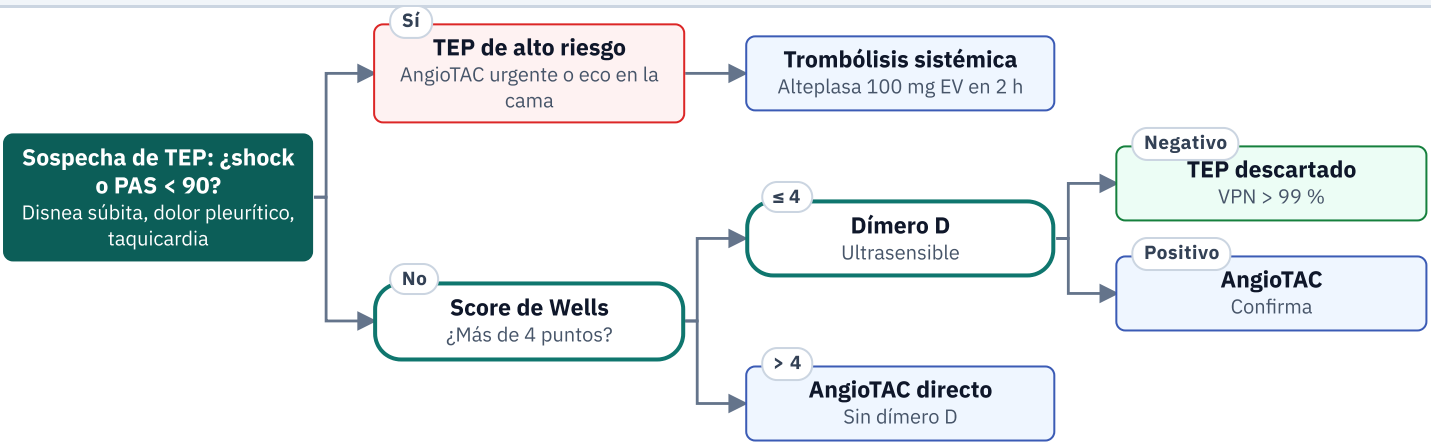
- En probabilidad clínica baja o intermedia de TEP (Wells **≤ 4**), el Dímero D negativo descarta la enfermedad con VPN > **99%**.
- En probabilidad clínica alta de TEP (Wells > 4), está formalmente contraindicado pedir Dímero D; se solicita Angio-TAC directo.
- El Angio-TAC de arterias pulmonares con contraste es el estándar de oro imagenológico en la práctica clínica actual.
- El TEP de alto riesgo (masivo) se define exclusivamente por inestabilidad hemodinámica (PAS < **90 mmHg** o shock obstructivo).
- **Tratamiento de elección en TEP de alto riesgo con shock**: Trombolisis sistémica urgente con rtPA (Alteplasa **100 mg** EV en **2 horas**).



**TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA**
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

## ALGORITMO · TEP: PRIMERO LA PRESIÓN, DESPUÉS WELLS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 4.4 · ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y TRATAMIENTO DEL TEP AGUDO (GUÍAS ESC)

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-19

| ESTRATO DE RIESGO | HEMODINAMIA | DISFUNCIÓN VD / TROPONINAS | TRATAMIENTO DE ELECCIÓN |
|---|---|---|---|
| **Alto Riesgo (Masivo)** | Shock o PAS < 90 mmHg persistente | Positivos (compromiso ventricular) | Trombolisis sistémica de urgencia (rtPA 100 mg EV) |
| **Riesgo Intermedio-Alto** | Normotenso (estable) | VD dilatado en eco Y Troponinas elevadas | Anticoagulación plena + Monitorización en UTI |
| **Riesgo Intermedio-Bajo** | Normotenso (estable) | Solo 1 positivo (eco o troponinas) | Anticoagulación plena en sala general |
| **Bajo Riesgo** | Normotenso (estable) | Ambos negativos (eco y troponinas normales) | Anticoagulación oral (ACOD) con alta precoz |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-19

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Estable, Wells ≤ 4** | Dímero D ultrasensible | AngioTAC de entrada |
| **Estable, Wells > 4** | AngioTAC directo | Pedir dímero D |
| **Shock o PAS < 90** | Trombólisis: alteplasa 100 mg EV en 2 h | Solo heparina en sala |

**REGLA DE ORO** **Shock o PAS < 90 = alto riesgo** — Trombólisis: alteplasa 100 mg en 2 h

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **67–69** (pág. 19) · solucionario págs. 33–34.

**Clase 4.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

# 4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.05.2.007 | Hemoptisis moderada,severa y masiva | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | 1.05.1.019 | Hemoptisis leve y mediana | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.05.1.004 | Bronquiectasias | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo | 4.01.2.018 | Hemoptisis masiva | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 2.01.4.026 | Test del sudor | Interpreta y emplea | | | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

- En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el shock hemorrágico.
- **Medida postural inmediata**: decúbito lateral sobre el lado que sangra para proteger el pulmón sano de la aspiración.
- El **90%** de las hemoptisis masivas proviene de las arterias bronquiales sistémicas a alta presión.
- El procedimiento intervencional de elección para detener el sangrado es la embolización arterial bronquial.
- El examen de elección para confirmar bronquiectasias es la TACAR, que muestra el "signo del anillo de sello".



**BRONQUIECTASIAS**
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 68

## ALGORITMO · HEMOPTISIS: PRIMERO LA VÍA AÉREA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 4.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOPTISIS VS HEMATEMESIS

| CARACTERÍSTICA | HEMOPTISIS | HEMATEMESIS |
|---|---|---|
| **Mecanismo de expulsión** | Tos y carraspeo | Náuseas y vómitos |
| **Color y aspecto** | Rojo rutilante brillante, espumosa | Rojo oscuro, pardo ("concho de café"), no espumosa |
| **pH químico** | Alcalino | Ácido |
| **Contenido asociado** | Mucus respiratorio, macrófagos alveolares | Restos alimentarios |
| **Pródromos** | Cosquilleo laringofaríngeo, opresión torácica | Dolor epigástrico, náuseas |
| **Etiologías comunes** | Bronquiectasias, Cáncer, TBC, Aspergiloma | Úlcera péptica, Várices esofágicas, Mallory-Weiss |

## TRAMPAS EUNACOM

clase resp-20

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Hemoptisis masiva del pulmón derecho** | Decúbito lateral derecho | Lado sano abajo o Trendelenburg |
| **Prioridad en la masiva** | Proteger la vía aérea | Reponer volumen primero |
| **Intubación** | Tubo grueso ≥ 8,0 mm | Tubo delgado |

**REGLA DE ORO** **Se muere de asfixia** — No de shock

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **70–72** (págs. 19–20) · solucionario pág. 34.

**Clase 4.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO TIER 3

# 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.2.008 | Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada que requiere ventilación mecánica | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar | |
| 1.05.4.010 | Gases en sangre arterial | Interpreta y emplea | |
| 1.05.5.012 | Ventilación mecánica no invasiva | Derivar a especialista | |
| 1.05.5.011 | Ventilación mecánica invasiva | Derivar a especialista | |
| 4.01.5.023 | Manejo ventilatorio básico | Realizar | |

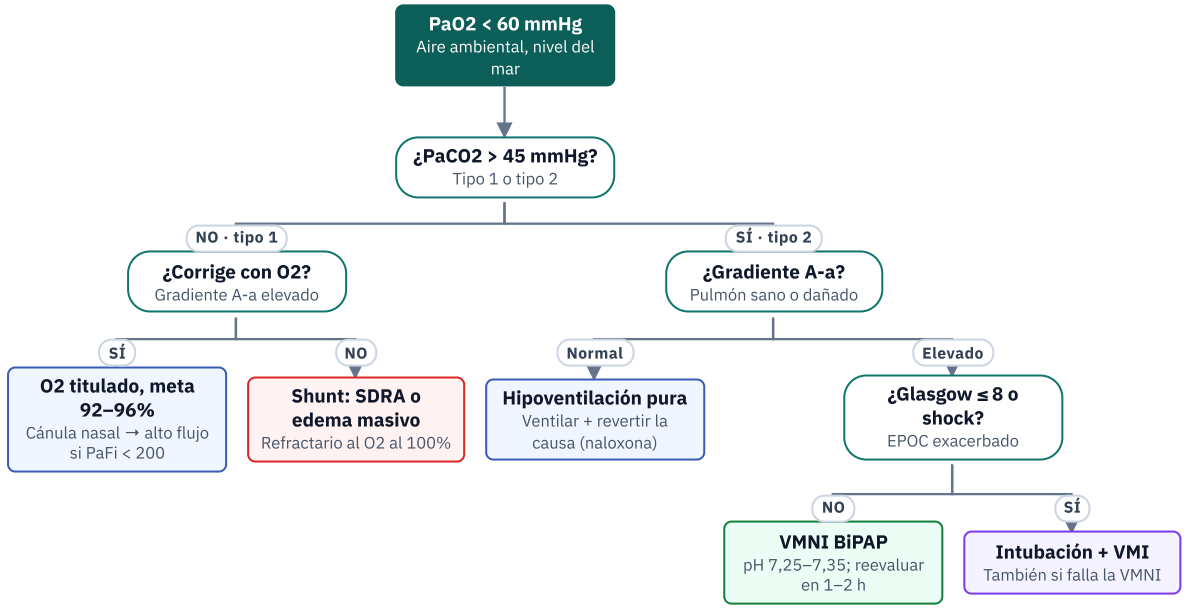
+ 6 códigos relacionados: 4.01.5.030 · 2.01.2.013 · 1.05.1.023 · 1.05.2.009 · 1.05.5.007 · 1.05.5.001

## LO QUE TE PREGUNTAN

- **Definición gasométrica de IRA**: PaO2 < **60 mmHg** respirando aire ambiental a nivel del mar (SatO2 < **90%**).
- IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 **≤ 45 mmHg**) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por daño parenquimatoso o vascular.
- IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > **45 mmHg**) secundaria a falla de bomba ventilatoria o fatiga muscular.
- La hipoventilación alveolar pura se diagnostica por hipercapnia con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< **15–20 mmHg**).
- El Shunt intrapulmonar (SDRA, edema alveolar masivo) es el único mecanismo que NO corrige con O2 al **100%**.
- La Mascarilla Venturi es de elección en pacientes retenedores de CO2 para evitar hipoventilación por exceso de FiO2.

## ALGORITMO · INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA: DE LOS GASES AL SOPORTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.1 · MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-21

| MECANISMO FISIOPATOLÓGICO | PAO2 | PACO2 | GRADIENTE A-A O2 | RESPUESTA A O2 100% |
|---|---|---|---|---|
| **Hipoventilación alveolar pura (Opioides, ACV)** | Disminuida | Elevada (> 45) | NORMAL (< 15-20) | Corrige rápidamente |
| **Desbalance V/Q bajo (NAC, EPOC, Asma)** | Disminuida | Normal o Baja | ELEVADO (> 20) | Corrige fácilmente |
| **Shunt Intrapulmonar (SDRA, Edema cardiogénico)** | Muy disminuida | Normal o Baja | MUY ELEVADO | REFRACTARIO a O2 100% |
| **Alteración de la Difusión (EPID avanzada)** | Baja en esfuerzo | Normal o Baja | ELEVADO | Corrige con O2 |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-21

| MECANISMO | PACO2 | GRADIENTE A-A | O2 AL 100% |
|---|---|---|---|
| **Baja PiO2 (altura > 3.000 m)** | Baja | Normal | Corrige |

**REGLA DE ORO** **IRA = PaO2 < 60 mmHg** — Aire ambiental, nivel del mar

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **75–81** (págs. 20–21) · solucionario págs. 35–36.

**Clase 5.1 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

# 5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.1.014 | Edema pulmonar no cardiogénico | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | |
| 1.05.5.011 | Ventilación mecánica invasiva | Derivar a especialista | |
| 1.01.4.003 | Radiografía de tórax | Interpreta y emplea | |
| 1.04.2.011 | Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19 | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

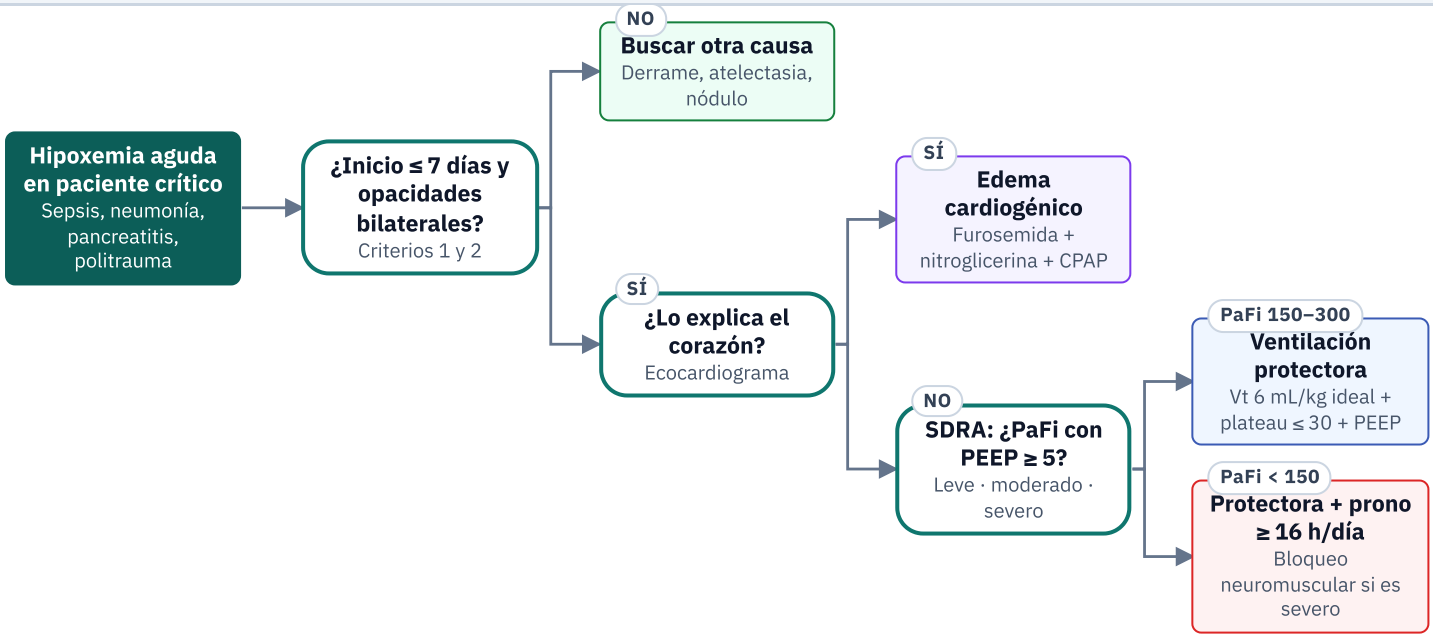
- **Criterios de Berlín**: inicio en **≤ 7 días**, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFiO2 con PEEP **≥ 5.**
- **Estratificación de Berlín**: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi **≤ 100 mmHg**).
- La ventilación protectora exige volumen corriente bajo de **6 mL/kg** según peso corporal IDEAL (no real).
- La presión meseta o plateau debe mantenerse siempre en **≤ 30 cmH**2O para prevenir barotrauma.
- En SDRA severo con PaFiO2 < **150 mmHg**, la posición decúbito prono por **≥ 16 h/día** reduce significativamente la mortalidad.



**DISTRÉS (SDRA)**
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 35

## ALGORITMO · SDRA: DIAGNÓSTICO DE BERLÍN Y VENTILACIÓN PROTECTORA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.2 · CLASIFICACIÓN DE BERLÍN DEL SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)

| CATEGORÍA SDRA | RELACIÓN PAFIO2 (CON PEEP ≥ 5) | MORTALIDAD ESTIMADA | INTERVENCIÓN DE IMPACTO COMPROBADO |
|---|---|---|---|
| **Leve** | 200 < PaFiO2 ≤ 300 mmHg | 27% | Ventilación protectora (Vt 6 mL/kg ideal) |
| **Moderado** | 100 < PaFiO2 ≤ 200 mmHg | 32% | PEEP optimizado + Evitar balance hídrico positivo |
| **Severo** | PaFiO2 ≤ 100 mmHg | 45% | Posición Prono precoz (≥ 16 h/d) + Bloqueo neuromuscular |

## TRAMPAS EUNACOM

clase resp-22

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **PaFi medida sin PEEP** | Medir con PEEP o CPAP ≥ 5 | Clasificar con cualquier PaFi |
| **Opacidades bilaterales + falla cardíaca** | Edema cardiogénico: diurético | Llamarlo SDRA |
| **Volumen corriente** | 6 mL/kg de peso ideal | Calcular con el peso real |

**REGLA DE ORO** **≤ 7 días + opacidades bilaterales** — No explicado por el corazón

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **82–83** (págs. 21–22) · solucionario pág. 36.

**Clase 5.2 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

# 5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

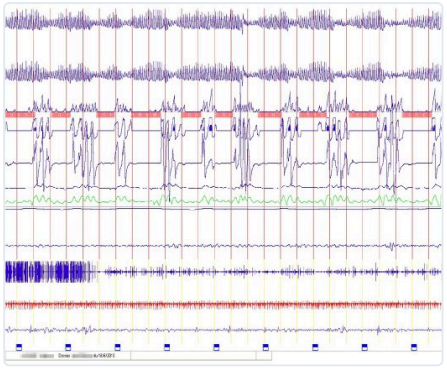
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

*Alta · Diagnóstico por Polisomnografía e indicación de CPAP nocturno*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.1.033 | Síndrome de apnea del sueño | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar | |
| 6.03.4.009 | Polisomnografía | | Emplea informe |

## LO QUE TE PREGUNTAN

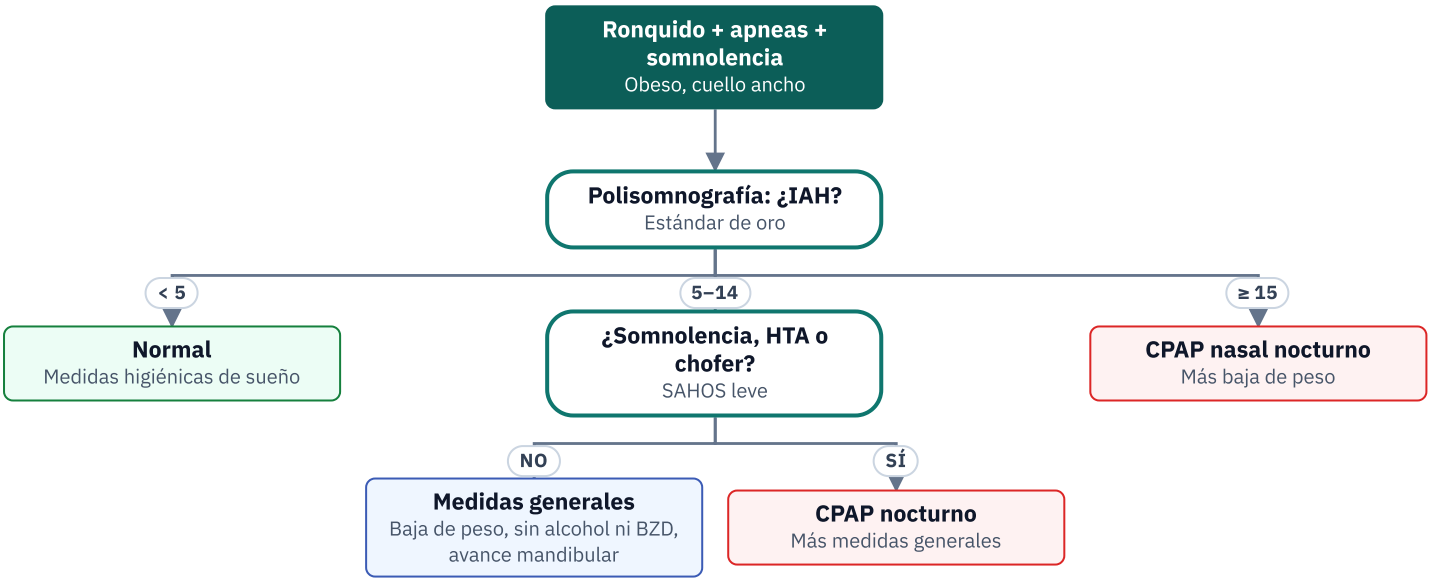
- **Tríada cardinal del SAHOS**: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia diurna excesiva.
- El principal factor de riesgo modificable para SAHOS es la obesidad (IMC > **30 kg**/m²).
- El examen confirmatorio de referencia indiscutido es la Polisomnografía nocturna.
- El punto de corte de IAH para clasificar SAHOS moderado a severo e indicar CPAP es IAH **≥ 15 eventos/hora**.
- El tratamiento médico de primera línea es el CPAP nasal nocturno; los sedantes y el alcohol están contraindicados.



**POLISOMNOGRAFÍA REAL**
Wikimedia Commons «Polysomnographie-apnees-5min2.png», CC BY-SA 3.0, GAllegre

## ALGORITMO · SAHOS: DE LA SOSPECHA AL CPAP

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.3 · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y ENFOQUE TERAPÉUTICO EN SAHOS

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-23

| SEVERIDAD DEL SAHOS | ÍNDICE DE APNEA-HIPOAPNEA (IAH) | MANIFESTACIÓN TÍPICA | CONDUCTA TERAPÉUTICA RECOMENDADA |
|---|---|---|---|
| **Normal** | < 5 eventos / hora | Sin patología respiratoria nocturna | Medidas higiénicas generales de sueño |
| **Leve** | 5 a 14 eventos / hora | Ronquido leve, somnolencia ocasional | Baja de peso, evitar alcohol/BZD, dispositivo avance mandibular |
| **Moderado** | 15 a 29 eventos / hora | Somnolencia diurna habitual, microdespertares | CPAP nocturno continuo (tratamiento de 1.ª línea) |
| **Severo** | ≥ 30 eventos / hora | Hipersomnia severa, riesgo vital vascular | CPAP nocturno continuo obligatorio + Control HTA |

**REGLA DE ORO** **Ronquido + apneas + somnolencia** — En obeso de cuello ancho

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **84–86** (pág. 22) · solucionario pág. 36.

**Clase 5.3 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

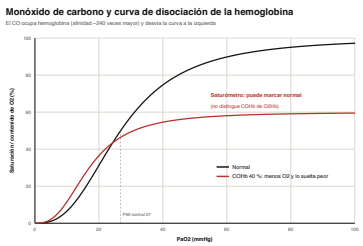
# 5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
4 preguntas reales 2013–2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.05.2.010 | Intoxicación por monóxido de carbono | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | |
| 1.05.1.024 | Intoxicación leve por CO y otros gases | Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo | |
| 1.05.4.014 | Saturometría arterial | Realiza, interpreta y emplea | |
| 1.05.3.001 | Contaminación ambiental | Conocimiento general | |

## LO QUE TE PREGUNTAN

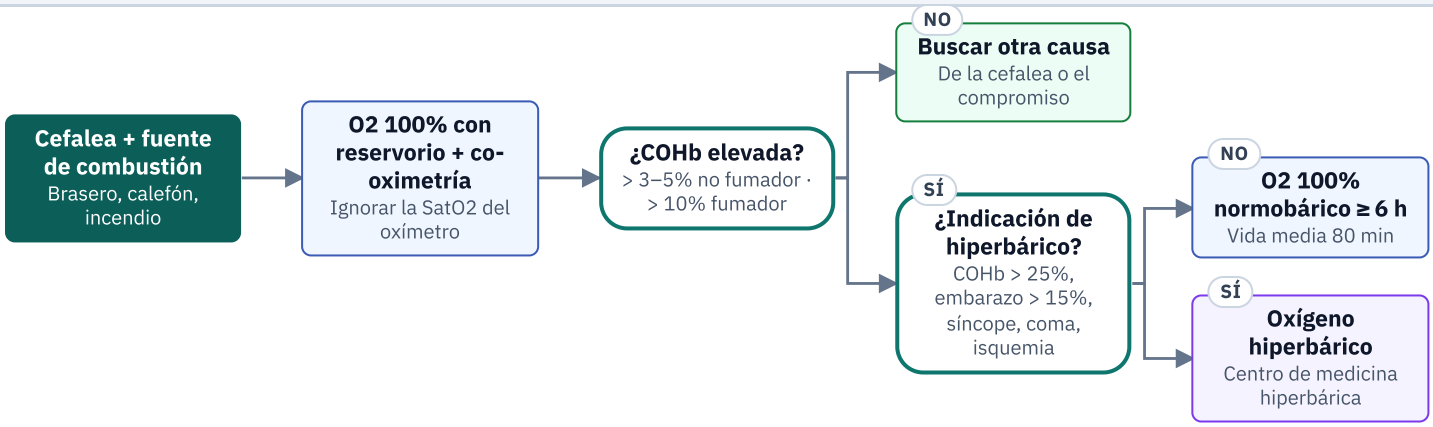
- La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca falsamente **100%**.
- El examen confirmatorio es la medición de Carboxihemoglobina (COHb) por Co-oximetría en gases sanguíneos.
- El tratamiento inmediato de primera línea es Oxígeno al **100%** con mascarilla con reservorio por al menos **6 horas**.
- El O2 al **100%** normobárico reduce la vida media de la COHb de **320 minutos** a solo **80 minutos**.
- **Indicaciones de Oxígeno Hiperbárico**: COHb > **25%**, embarazadas con COHb > **15%**, síncope/coma o isquemia miocárdica.




**CURVA DE DISOCIACIÓN**
Dibujo propio (esquema)

## ALGORITMO · MONÓXIDO DE CARBONO: DE LA SOSPECHA A LA CÁMARA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.4 · CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DE LA CARBOXIHEMOGLOBINA Y TIEMPOS DE VIDA MEDIA

| MODALIDAD DE OXIGENOTERAPIA | PRESIÓN Y FRACCIÓN DE O2 | VIDA MEDIA DE LA COHB | LUGAR DE ADMINISTRACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Aire Ambiental** | 1 ATA (FiO2 21%) | 320 minutos (~ 5.5 horas) | Habitación estándar |
| **O2 al 100% Normobárico** | 1 ATA (FiO2 100% Mascarilla Reservorio) | 80 minutos (~ 1.3 horas) | Servicio de Urgencias / Reanimación |
| **Oxígeno Hiperbárico (OHB)** | 2.5 a 3 ATA en Cámara Hiperbárica | 20 a 25 minutos | Centro de Medicina Hiperbárica especializado |

## TRAMPAS EUNACOM

clase resp-24

| ESCENARIO | CONDUCTA CORRECTA | ERROR FRECUENTE |
|---|---|---|
| **Cefalea + brasero, SatO2 99%** | O2 100% y co-oximetría | Alta por saturación normal |
| **Confirmar la sospecha** | Carboxihemoglobina | Gases convencionales o TAC de cerebro |
| **COHb 12%, sin síntomas graves** | O2 100% normobárico | Cámara hiperbárica |

**REGLA DE ORO** **SatO2 normal no descarta CO** — El oxímetro marca falsamente 100%

**PRACTICA** **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **87–90** (págs. 22–23) · solucionario pág. 37.

**Clase 5.4 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

# 5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental

PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

*Media · RCP que parte por ventilaciones, no drenar agua, hipotermia con recalentamiento activo y manipulación cuidadosa*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.2.001 | Asfixia por inmersión | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo | 1.07.1.011 | Hipotermia | Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo |

## LO QUE TE PREGUNTAN

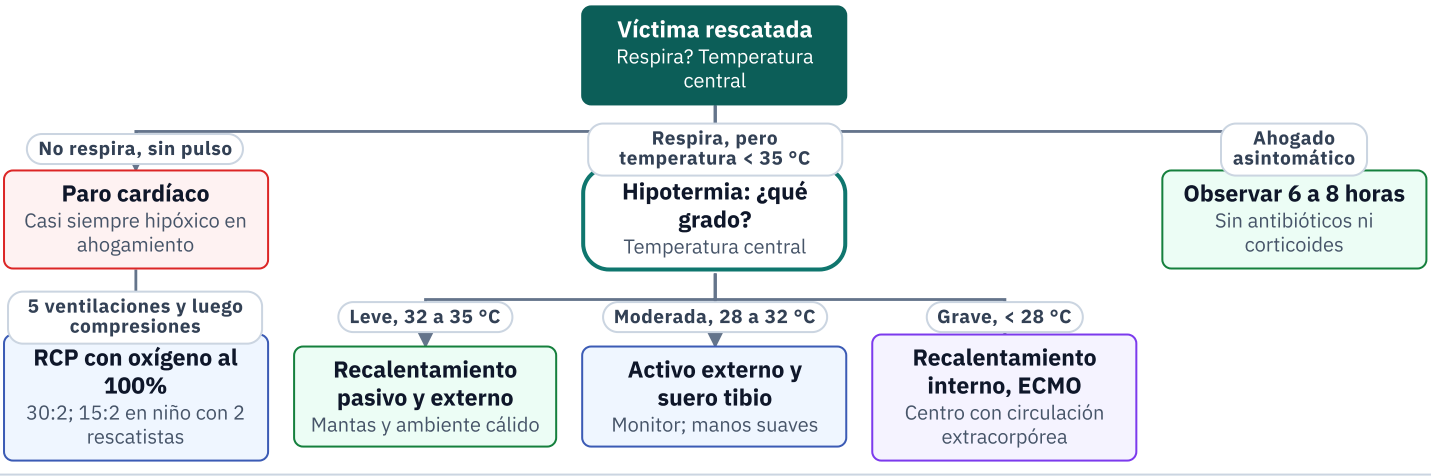
- **El paro en el ahogamiento es hipóxico**: la RCP parte con 5 ventilaciones de rescate y luego compresiones.
- No se pierde tiempo en drenar el agua (Heimlich o posición boca abajo): no sirve y aumenta el vómito.
- **Todo ahogado se observa 6 a 8 horas**: puede desarrollar edema pulmonar o SDRA tardío.
- **Hipotermia es temperatura central menor de 35 °C**: leve 32-35, moderada 28-32, grave menor de 28 (ondas J de Osborn).
- Recalentamiento escalonado y manipulación cuidadosa por riesgo de fibrilación ventricular; la bradicardia no responde a atropina.
- **Nadie está muerto hasta que está tibio y muerto**: en paro hipotérmico la RCP se prolonga hasta recalentar.



**EDEMA NO CARDIOGÉNICO, SDRA**
Harrison 21.ª ed., Fig. 301-2

## ALGORITMO · AHOGAMIENTO E HIPOTERMIA ACCIDENTAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción




## TABLA 5.5 · HIPOTERMIA: CLASIFICACIÓN POR TEMPERATURA CENTRAL Y CONDUCTA

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE RESP-25

| GRADO | TEMPERATURA CENTRAL | CUADRO CLÍNICO | MANEJO |
|---|---|---|---|
| **Leve** | 32 a 35 °C | Temblor, taquicardia, taquipnea, confusión | Recalentamiento pasivo y externo |
| **Moderada** | 28 a 32 °C | Letargo, sin temblor, bradicardia, ondas J, FA | Activo externo + suero tibio · monitor |
| **Grave** | Menor de 28 °C | Coma, bradicardia extrema, FV o asistolia | Recalentamiento interno, ECMO · RCP prolongada |

## TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase resp-25

| DATO | DECISIÓN | ERROR TÍPICO |
|---|---|---|
| **Ahogado en paro** | 5 ventilaciones y luego compresiones | Heimlich o boca abajo para drenar agua |
| **Ahogado asintomático, Rx y SatO2 normales** | Observar 6 a 8 horas | Alta inmediata, o antibióticos y corticoides |

**REGLA DE ORO** **Ventilar primero: 5 ventilaciones de rescate** — Luego compresiones

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, pregunta **73** (pág. 20) · solucionario pág. 34.

**Clase 5.5 en video**
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

# Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 25 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR** | |
| **1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar** | pág. 3 |
| **≥ 12%** Y **≥ 200 mL** — En el VEF1 o la CVF | DOSIS |
| VEF1/CVF < 0,70 define — El VEF1 post-BD gradúa | CORTE |
| **1.2 Crisis Asmática en el Adulto** | pág. 4 |
| SatO2 > **93%** · PEF > **70%** — Al aire ambiente | CORTE |
| Control en **≤ 7 días** hábiles — En APS o policlínico | CORTE |
| **1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES** | pág. 5 |
| Espirometría normal no descarta — Metacolina: VEF1 cae > **20%** | META |
| Síntomas diurnos > **2 veces**/semana — En las últimas **4 semanas** | CORTE |
| Escalón 1–2: budesonida/formoterol SOS — 160/**4,5 mcg**, 1 puff a demanda | DOSIS |
| **1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable** | pág. 6 |
| Oxígeno domiciliario > **15 h**/día — Meta SatO2 **≥ 90%** | META |
| GOLD 1 **≥ 80%** · GOLD 2 **50–79%** — Del predicho | CORTE |
| GOLD 3 **30–49%** · GOLD 4 < **30%** — Describe el pulmón | CORTE |
| **1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)** | pág. 7 |
| Prednisona **40 mg** por **5 días** — Sin descenso | DOSIS |
| Paro inminente · Glasgow < 8 — Sin protección de la vía aérea | CORTE |
| SatO2 **88–92 %** — O PaO2 entre 55 y **65 mmHg** | CORTE |
| **BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES** | |
| **2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65** | pág. 8 |
| U: urea > **42 mg/dL** — O BUN > **19 mg/dL** | DOSIS |
| B: PAS < 90 o PAD **≤ 60** — Blood pressure | CORTE |
| GES **≥ 65 años** — Antibiótico en < **24 horas** | CORTE |
| **2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES** | pág. 9 |
| < 65 sano: amoxicilina — **1 g** c/**8 h** · alergia: macrólido | DOSIS |
| Azitromicina **500 mg**/día — Por **3 a 5 días** | DOSIS |
| **2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa** | pág. 10 |
| > 25 leucocitos, < 10 epiteliales — Si no, es saliva | CORTE |
| Levofloxacino **750 mg**/día — O azitromicina EV | DOSIS |
| **2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares** | pág. 11 |
| Ampicilina/sulbactam EV — **1,5 a 3 g** cada **6 horas** | DOSIS |
| Luego amoxicilina/clavulánico VO — 875/**125 mg** cada **8 a 12 horas** | DOSIS |
| **2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento** | pág. 12 |
| Una dosis al recién nacido **≥ 2.000 g** — No se revacuna | DOSIS |
| Pleural: **6 meses**, sin cambios — Exudado linfocítico con ADA > 40 | CORTE |
| Influenza anual — Asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis, > **65 años** | CORTE |
| **BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS** | |
| **3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light** | pág. 13 |
| Rx de pie: más de **150–200 mL** — Borra el ángulo costofrénico | DOSIS |
| Proteínas > 0,5 · LDH > 0,6 · LDH > 2/3 — Líquido y suero al mismo tiempo | CORTE |

# Números que tienes que saber · continuación

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental** (cont.) | pág. 27 |
| Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico. | CORTE |
| **3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural** | pág. 14 |
| **2 a 4 semanas** en total — Mínimo **14 días** EV, luego oral | TIEMPO |
| **3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario** | pág. 15 |
| Pequeño: oxígeno + observar — Menos de **2 cm** en el hilio | CORTE |
| Fuga aérea persistente — Burbujeo después de **48 a 72 horas** | TIEMPO |
| **3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático** | pág. 16 |
| Hemotórax masivo — Matidez + sangre **≥ 1.500 mL** | DOSIS |
| Toracotomía: **1.500 mL** o **200 mL**/h — Por **2 a 4 horas** | DOSIS |
| **3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa** | pág. 17 |
| Linfocitos > **50 %**: TBC o cáncer — El ADA decide la sospecha | CORTE |
| Un ADA en líquido pleural **≥ 40 U/L** tiene altísima especificidad para pleuritis tuberculosa. | CORTE |
| Citología del líquido — **60 %** en la 1.ª muestra; **80–85 %** con la 2.ª | CORTE |
| **BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR** | |
| **4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner** | pág. 18 |
| Menor de **6 mm**, bordes lisos — Netos y regulares | CORTE |
| **6–8 mm**: TAC seriada — Más de **8 mm**: PET-CT o tejido | CORTE |
| **4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial** | pág. 19 |
| Células grandes: **10 %** — Periférico, indiferenciado y agresivo | CORTE |
| Epidermoide: **25–30 %** — Muy ligado al tabaco, tiende a cavitar | CORTE |
| Adenocarcinoma: **40–50 %** — El más frecuente, también en no fumadores | CORTE |
| **4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática** | pág. 20 |
| TACAR: NIU = FPI — Sin biopsia si es típico y > **60 años** | CORTE |
| Crépitos secos tipo velcro — Teleinspiratorios, bibasales, en más del **80 %** | CORTE |
| Población habitual · Hombres > **60-65 años**, fumadores · Mujeres jóvenes a maduras, no fumadoras | CORTE |
| **4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación** | pág. 21 |
| FC > **100 lpm** — +1,5 | CORTE |
| Wells **≤ 4**: dímero D — Negativo descarta | CORTE |
| Paro inminente: **0,6 mg/kg** en **15 min** — Bolo rápido | DOSIS |
| **4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias** | pág. 22 |
| Leve: < **30 mL**, estrías — Mediana: 30 a **150–200 mL** | DOSIS |
| > **150–200 mL** en **1 hora** — O > **500–600 mL** en **24 horas** | DOSIS |
| Embolización bronquial — **90 %** de origen bronquial | CORTE |
| **BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO** | |
| **5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)** | pág. 23 |
| PaO2 < **60 mmHg** — Con o sin PaCO2 > **45 mmHg** | CORTE |
| Índice ROX < 3,88 — Alto riesgo de falla del alto flujo | CORTE |
| **5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín** | pág. 24 |
| **6 mL/kg** de peso ideal — Plateau **≤ 30 cmH**2O | DOSIS |
| PaFi < 150: prono **≥ 16 h** — Reduce la mortalidad | CORTE |
| **5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)** | pág. 25 |
| Severo: IAH **≥ 30** — El corte de CPAP es 15 | CORTE |

# Números que tienes que saber · continuación

| DATO | TIPO |
|---|---|
| **5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental** (cont.) | pág. 27 |
| IAH **≥ 15**: CPAP nasal — O leve con somnolencia, HTA o chofer | CORTE |
| **5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo** | pág. 26 |
| COHb > **25%** — En cualquier paciente | CORTE |
| O2 **100%** con reservorio, **≥ 6 h** — Vida media: 320 → **80 min** | CORTE |
| **5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental** | pág. 27 |
| Oxígeno con meta SatO2 > **94%** — CPAP, VMNI o intubación si persiste | META |
| Peor pronóstico — Sumersión > **10 min**, asistolia, pH < 7,0 | CORTE |

# Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

| SITUACIÓN | FÁRMACO / ESQUEMA | DETALLE |
|---|---|---|
| **1.2 Crisis Asmática en el Adulto** | | pág. 4 |
| La primera hora · Oxígeno y broncodilatadores | **Salbutamol 4–8 puff cada 20 min** | Durante la 1ª hora, con aerocámara |
| La primera hora · Oxígeno y broncodilatadores | **+ Ipratropio en moderada y grave** | 4–8 puff o **500 mcg** nebulizado cada **20 min** |
| Receta de egreso | **Prednisona 40 mg/día por 5–7 días** | Sin esquema descendente |
| Receta de egreso | **SABA de rescate + corticoide inhalado** | Iniciar o escalar la mantención |
| **1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES** | | pág. 5 |
| Escalones GINA, vía preferida · Escalones 1 a 3 | **Escalón 1–2: budesonida/formoterol SOS** | 160/**4,5 mcg**, 1 puff a demanda |
| Qué hace el médico general · Deriva al broncopulmonar | **Eosinófilos, IgE; biológicos o termoplastía** | |
| **1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable** | | pág. 6 |
| Lo que cambia el curso | **Diuréticos con cuidado** | Alcalosis metabólica reduce el impulso respiratorio |
| **1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)** | | pág. 7 |
| Qué gérmenes y con qué · Primera línea en Chile | **Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg** | Cada **12 h** por **5 a 7 días** |
| Qué gérmenes y con qué · Primera línea en Chile | **Azitromicina 500 mg/día 3–5 días · cefuroximo 500 mg c/12 h** | |
| Broncodilatador y corticoide · Broncodilatación | **Salbutamol + ipratropio** | 4 a 8 puff de cada uno, con aerocámara |
| Tratar la exacerbación | **Diurético de asa con cautela** | Vigilar potasio y bicarbonato |
| **2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES** | | pág. 9 |
| Menor de 65, sin comorbilidades · Primera línea | **Amoxicilina 1 g c/8 h oral** | Por **5 a 7 días** |
| Sala general · Primera línea | **Ceftriaxona 1–2 g/día EV** | O ampicilina/sulbactam **1,5 g** c/**6 h** EV |
| Unidad de cuidados intensivos · Primera línea | **Ceftriaxona 2 g + levofloxacino 750 mg** | Ambos EV, al día |
| Unidad de cuidados intensivos · Primera línea | **O ceftriaxona + azitromicina EV** | Betalactámico + atípico |
| **2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa** | | pág. 10 |
| Intracelular | **Levofloxacino 750 mg/día** | O azitromicina EV |
| El que no protege su vía aérea · Cubrir anaerobios | **Ampicilina/sulbactam 1,5–3 g c/6 h EV** | O amoxicilina/clavulánico |
| Aparece después de 48 horas · Antipseudomónico | **Piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h** | O cefepime **2 g** c/**8 h** EV |
| Aparece después de 48 horas · Antipseudomónico | **+ vancomicina si sospecha de SAMR** | Previa toma de cultivos |
| **2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares** | | pág. 11 |
| Médico, anaerobios y largo · Esquema de elección | **Ampicilina/sulbactam EV** | **1,5 a 3 g** cada **6 horas** |
| Médico, anaerobios y largo · Esquema de elección | **Luego amoxicilina/clavulánico VO** | 875/**125 mg** cada **8 a 12 horas** |
| **4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial** | | pág. 19 |
| Manejo inicial | **Dexametasona + protección gástrica** | Para el edema |
| **4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática** | | pág. 20 |
| Toxicidad intersticial | **Amiodarona** | La causa más frecuente en cardiología |

## Fármacos de primera línea · continuación

| SITUACIÓN | FÁRMACO / ESQUEMA | DETALLE |
|---|---|---|
| **5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín** (cont.) | | pág. 24 |
| Toxicidad intersticial | **Metotrexato, bleomicina, nitrofurantoína** | Esta última en uso crónico |
| **4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación** | | pág. 21 |
| Anticoagular · Primera línea | **Rivaroxabán** | **15 mg** c/**12 h** por **21 días**, luego **20 mg**/día |
| Anticoagular · Primera línea | **Apixabán** | **10 mg** c/**12 h** por **7 días**, luego **5 mg** c/**12 h** |
| Anticoagular · Alternativa parenteral | **Enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC** | De elección en cáncer activo o embarazo |
| Anticoagular · Alternativa parenteral | **Traslape a acenocumarol o warfarina** | Meta INR 2–3 |
| **4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias** | | pág. 22 |
| Clínica, diagnóstico y manejo · Crónico | **Antibióticos en las exacerbaciones** | |
| Clínica, diagnóstico y manejo · Crónico | **Vacunas** | Antiinfluenza y antineumocócica |
| **5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín** | | pág. 24 |
| Derivar a UCI | **Dexametasona 6 mg por 10 días** | Si requiere oxígeno; anticoagulación profiláctica |

# GES de Respiratorio

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Diagnóstico y Confirmación de Asma y EPOC en APS**

Tema **1.1** · Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar
`1.05.4.005` · `1.05.4.012`
pág. 3

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de Urgencia del Asma Bronquial Moderada o Grave**

Tema **1.2** · Crisis Asmática en el Adulto
`1.05.2.004` · `1.05.4.009` · `1.05.4.010`
pág. 4

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Asma Bronquial en Personas de 15 años y más**

Tema **1.3** · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES
`1.05.1.003` · `1.05.1.002` · `1.05.4.005`
pág. 5

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en Personas de 15 años y más**

Tema **1.4** · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable
`1.05.1.017` · `1.05.1.016` · `1.05.4.005`
pág. 6

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de la Exacerbación Aguda del EPOC**

Tema **1.5** · Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)
`1.05.2.006` · `1.05.5.012` · `1.05.4.010`
pág. 7

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía Adquirida en la Comunidad de Manejo Ambulatorio en Personas de 65 años y más**

Tema **2.1** · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65
`1.05.1.027` · `1.05.4.001` · `1.05.1.005`
pág. 8

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía en el Adulto de 65 años y más (Tratamiento en menos de 24 horas)**

Tema **2.2** · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES
`1.05.1.028`
pág. 9

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Tuberculosis en Todas sus Formas (Garantía de Acceso, Diagnóstico y Tratamiento)**

Tema **2.5** · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento
`1.05.1.036` · `1.05.3.003` · `1.05.4.004`
pág. 12

# Fármacos de primera línea · continuación

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Politraumatizado Grave (Manejo Inmediato de Lesiones Torácicas con Riesgo Vital)**

Tema **3.4** · Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático
`1.05.2.011` · `1.05.2.013` · `1.05.5.004`
pág. **16**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Pulmón y Tuberculosis**

Tema **3.5** · Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa
`1.05.1.013` · `1.05.1.010` · `1.05.5.002`
pág. **17**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Sospecha de Cáncer Pulmonar**

Tema **4.1** · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner
`1.05.1.038` · `4.01.1.038` · `1.05.4.002`
pág. **18**

**GES** **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más**

Tema **4.2** · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial
`1.05.1.007` · `4.01.1.039` · `1.05.1.034`
pág. **19**

**Sin garantía GES específica** (13 temas): 2.3 · 2.4 · 3.1 · 3.2 · 3.3 · 4.3 · 4.4 · 4.5 · 5.1 · 5.2 · 5.3 · 5.4 · 5.5. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

# Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

## DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **2.5** Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento ..... 12
- ★★★ **4.2** Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial ..... 19
- ★★★ **4.4** Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación ..... 21
- ★★★ **2.1** Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 ..... 8
- ★★★ **1.3** Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES ..... 5

**Practica:** Libro Gordo Respiratorio, preguntas 11–14, 19–24, 35–36, 55, 58–62, 67–69.

## DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **4.3** Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática ..... 20
- ★★★ **1.5** Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) ..... 7
- ★★★ **1.4** Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable ..... 6
- ★★★ **4.5** Hemoptisis y Bronquiectasias ..... 22

**Practica:** Libro Gordo Respiratorio, preguntas 15–18, 63–66, 70–72.

## DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.1** Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light ..... 13
- ★★☆ **3.5** Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa ..... 17
- ★★☆ **4.1** Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner ..... 18
- ★★☆ **5.3** Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) ..... 25

**Practica:** Libro Gordo Respiratorio, preguntas 38–40, 54, 56–57, 84–86.

## DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **1.1** Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar ..... 3
- ★★☆ **5.1** Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) ..... 23
- ★★☆ **5.4** Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo ..... 26
- ★★☆ **3.2** Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural ..... 14

**Practica:** Libro Gordo Respiratorio, preguntas 3–7, 41–46, 75–81, 87–90.

## DÍA 5

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.3** Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario ..... 15
- ★☆☆ **2.4** Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares ..... 11
- ★☆☆ **1.2** Crisis Asmática en el Adulto ..... 4
- ★☆☆ **2.2** Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES ..... 9

**Practica:** Libro Gordo Respiratorio, preguntas 8–10, 25–26, 31–34, 47–49.

## DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **2.3** Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa ..... 10
- ★☆☆ **3.4** Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático ..... 16
- ★☆☆ **5.2** Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín ..... 24
- ★☆☆ **5.5** Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental ..... 27

**Practica:** Libro Gordo Respiratorio, preguntas 27–30, 37, 50–53, 73, 82–83.

## DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 28
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.3 · 1.4 · 1.5 · 2.1 · 2.5 · 4.2 · 4.3 · 4.4 · 4.5
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Respiratorio en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

# Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

## ★★★ Prioridad alta · 9 temas


17 2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento GES ..... 12
15 4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial GES ..... 19
15 4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación ..... 21
14 2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 GES ..... 8
13 1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES GES ..... 5
9 4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática ..... 20
8 1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) GES ..... 7
7 1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable GES ..... 6
7 4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias ..... 22


## ★★ Prioridad media · 9 temas


6 3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light ..... 13
6 3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa GES ..... 17
5 4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner GES ..... 18
5 5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) ..... 25
4 1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar GES ..... 3
4 5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) ..... 23
4 5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo ..... 26
3 3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural ..... 14
3 3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario ..... 15


## ★ Prioridad baja · 7 temas


2 2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares ..... 11
1 1.2. Crisis Asmática en el Adulto GES ..... 4
1 2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES GES ..... 9
1 2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa ..... 10
0 3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático GES ..... 16
0 5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín ..... 24
0 5.5. Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental ..... 27